ATLAS

CLÍNICO-GEOMÉTRICO DEL ESPECTRO AFECTIVO

Nosología · fenomenología · curso · incertidumbre



Fernando José Segovia Vera

Modelo del atlas · edición revisada y ampliada v3.1 · 3 noviembre 2026

Edición revisada · evidencia atribuida · geometría conceptual sin calibración individual.

F criterio formal · E hallazgo empírico · I interpretación · H hipótesis · G geometría editorial

Cómo leer este atlas

01 · Diagnóstico

Las categorías DSM-5-TR e ICD-11 delimitan episodios y trastornos. El criterio diagnóstico se lee en texto; ninguna distancia gráfica lo sustituye.

02 · Dimensiones

Ánimo depresivo, activación, sueño, función y psicopatología concomitante pueden variar de forma parcialmente independiente.

03 · Curso

Las curvas son viñetas geométricas; altura, pendiente, área y grosor no son frecuencias poblacionales, pronósticos ni dosis.

RECORRIDO EDITORIAL

04–07	Matriz fenomenológica · 24 perfiles × 21 variables
08–09	Cartografía de dimensiones y proyecciones
10–18	Nueve láminas longitudinales; cursos 10–13 en pp. 24, 33, 34 y 35
19–20	Transiciones, moduladores y fármacos
21	Auditoría crítica de originales
22–25	Ampliación clínica I: precisiones, espectro, curso inducido y psicosis
26–42	Ampliación II: evaluación, riesgo, mixticidad, tratamiento, periparto, sustancias y guía
43–54	Método, fuentes normativas y bibliografía verificada

Clave epistemológica: F = criterio formal; E = hallazgo empírico; I = interpretación clínica; H = hipótesis o propuesta; G = geometría editorial no calibrada.

F · resumen de criterios; alcance de cotejo en p. 43 | fuentes N1–N4

Gramática diagnóstica y límites

Depresión mayor

DSM-5-TR / ICD-11

Episodio depresivo mayor; el trastorno se clasifica como único o recurrente si no hay historia de manía o hipomanía.

Depresión persistente

DSM-5-TR

Ánimo deprimido crónico. DSM-5-TR retiró especificadores inaplicables; la persistencia no limita la intensidad. Véanse N2 y la nota operativa de p. 22.

Bipolar II

DSM-5-TR

Al menos un episodio hipomaníaco y uno depresivo mayor; nunca un episodio maníaco.

Bipolar I

DSM-5-TR

Al menos un episodio maníaco. El episodio depresivo mayor es frecuente, pero no requisito diagnóstico.

Ciclotimia

DSM-5-TR / ICD-11

DSM: síntomas subumbrales. ICD-11 permite periodos hipomaníacos umbral; sus reglas no son intercambiables. Véase p. 22.

Mixticidad

DSM / ICD / propuesta

“Con características mixtas” es especificador DSM; ICD-11 reconoce episodio mixto en bipolar I. La mezcla clínica amplia de Koukopoulos es propuesta.

Ciclación rápida

DSM-5-TR / ICD-11

Modificador de curso en bipolar I o II: cuatro o más episodios del estado de ánimo en 12 meses; cambios horarios no equivalen a episodios.

Psicosis

DSM-5-TR / ICD-11

La psicosis durante la elevación sindrómica sitúa el episodio en el campo de la manía, no de la hipomanía. La psicosis depresiva exige caracterización propia.

La atribución diagnóstica requiere entrevista, duración, deterioro, exclusiones y contexto. La figura no resuelve el diagnóstico diferencial con sustancias, enfermedad médica o trastornos psicóticos.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda A

Experiencia afectiva y activación

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Ánimo depresivo	Anhedonia	Ansiedad	Irritabilidad	Mezcla simultánea	Activación subjetiva	Pensamiento acelerado
01	Depresión única, remisión completa	D	R	R	V	V	·	·	·
02	Depresión única, residuo	D	R	R	V	V	·	·	·
03	Depresión recurrente, remisión	D	R	R	V	V	·	·	·
04	Depresión recurrente, residuo	D	R	R	V	V	·	·	·
05	Depresión persistente, curso puro	D	R	V	V	V	·	·	·
06	Persistente + episodio mayor	D	R	R	V	V	·	·	·
07	Depresión breve recurrente	O	R	·	V	V	·	·	·
08	Depresión: patrón estacional	S	R	·	V	V	·	·	·
09	Depresión + anxious distress	S	R	·	R	V	·	·	·
10	Depresión melancólica	S	R	R	V	V	·	·	·
11	Depresión: características atípicas	S	R	·	V	V	·	·	·
12	Depresión con psicosis	S	R	R	V	V	·	·	·
13	Depresión + características mixtas DSM	S	R	·	V	V	R	V	V
14	Depresión + elevación breve	O	R	R	V	V	·	R	·
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	R	·	V	V	·	R	·
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	R	R	V	V	·	·	V
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	R	·	V	V	·	R	V
18	Bipolar II, depresión mixta	S	R	R	V	V	R	R	V
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	·	·	V	·	R	V
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	R	R	V	V	·	·	V
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	·	·	V	·	R	V
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	R	·	V	V	R	R	V
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	·	·	·	·	·	·
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	·	·	·	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I.

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda B

Expresión episódica

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Hipomanía (episodio)	Manía	Psicosis en episodio	Enlentecimiento	Agitación	Menor necesidad sueño	Alteración sueño
01	Depresión única, remisión completa	D	·	·	·	·	·	·	V
02	Depresión única, residuo	D	·	·	·	·	·	·	V
03	Depresión recurrente, remisión	D	·	·	·	·	·	·	V
04	Depresión recurrente, residuo	D	·	·	·	·	·	·	V
05	Depresión persistente, curso puro	D	·	·	·	·	·	·	V
06	Persistente + episodio mayor	D	·	·	·	·	·	·	V
07	Depresión breve recurrente	O	·	·	·	·	·	·	V
08	Depresión: patrón estacional	S	·	·	·	·	·	·	V
09	Depresión + anxious distress	S	·	·	·	·	·	·	V
10	Depresión melancólica	S	·	·	·	R	·	·	R
11	Depresión: características atípicas	S	·	·	·	·	·	·	V
12	Depresión con psicosis	S	·	·	R	·	·	·	V
13	Depresión + características mixtas DSM	S	·	·	·	·	V	V	V
14	Depresión + elevación breve	O	·	·	·	·	·	·	V
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	·	·	·	·	·	·	V
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	R	·	·	·	·	V	V
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	R	·	·	·	·	V	V
18	Bipolar II, depresión mixta	S	R	·	·	·	V	V	V
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	R	·	·	·	V	V
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	·	R	·	·	·	V	V
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	R	·	·	·	V	V
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	·	R	·	·	V	V	V
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	·	·	·	·	·	V
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	R	·	·	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I.

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda C

Curso e impacto

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Persistencia	Recurrencia	Carga residual	≥4 episodios/año	Impacto funcional	Reactividad del ánimo	Estacionalidad
01	Depresión única, remisión completa	D	·	·	·	·	R	·	·
02	Depresión única, residuo	D	·	·	R	·	R	·	·
03	Depresión recurrente, remisión	D	·	R	V	·	R	·	·
04	Depresión recurrente, residuo	D	·	R	R	·	R	·	·
05	Depresión persistente, curso puro	D	R	·	R	·	R	·	·
06	Persistente + episodio mayor	D	R	·	R	·	R	·	·
07	Depresión breve recurrente	O	·	R	V	·	R	·	·
08	Depresión: patrón estacional	S	·	R	V	·	R	·	R
09	Depresión + anxious distress	S	·	·	·	·	R	·	·
10	Depresión melancólica	S	·	·	·	·	R	V	·
11	Depresión: características atípicas	S	·	·	·	·	R	R	·
12	Depresión con psicosis	S	·	·	·	·	R	·	·
13	Depresión + características mixtas DSM	S	·	·	·	·	R	·	·
14	Depresión + elevación breve	O	·	·	·	·	R	·	·
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	R	R	V	·	R	·	·
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	·	R	R	·	R	·	·
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	·	R	V	·	R	·	·
18	Bipolar II, depresión mixta	S	·	·	·	·	R	·	·
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	·	·	·	R	·	·
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	·	R	V	·	R	·	·
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	R	V	·	R	·	·
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	·	·	·	·	R	·	·
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	R	V	R	R	·	·
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	·	·	R	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I. Reactividad del ánimo: R = conservada (fila 11); V en la fila 10 = puede estar ausente (p. 22).

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Conectores entre perfiles y capas

Familias diagnósticas

Depresiva
01–06 + capas 08–13

Otra especificada
07 · 14

Ciclotímica
15

Bipolar II
16–18

Bipolar I
19–22

Capas que atraviesan familias

Características mixtas	13 · 18 · 22	capa formal; propuesta amplia en p. 23
Psicosis	12 · 24	anotar episodio y relación temporal
Ciclación rápida	23	frecuencia de episodios umbral
Otros especificadores	08–11	estación, ansiedad, melancolía, atipicidad

Los conectores indican comparación y solapamiento fenomenológico, no conversión inevitable entre diagnósticos.

Una depresión con síntomas mixtos no equivale por sí sola a bipolaridad. El primer episodio maníaco puede reclasificar longitudinalmente un antecedente depresivo; el diagrama no asigna probabilidades.

G · geometría conceptual | sin datos de distribución | fundamentos dimensionales: P04, P05

Cartografía de dimensiones, no de gravedad

G · El plano representa combinaciones de síntomas; los diagnósticos no reciben posiciones ni distancias.
I · P04 respalda separar activación y valencia depresiva; P05 describe activación/inhibición como un eje más un componente emocional, por lo que no sostiene por sí solo que ambos ejes sean independientes.

↑ ACTIVACIÓN

Activación sin depresión prominente

Coexistencia alta–alta

Mixticidad como capa de síntomas concurrentes; su atribución formal depende del sistema y del episodio.

Pocos síntomas en ambos ejes

No informa por sí solo sobre función o residuo.

Depresión con activación baja

SÍNTOMAS DEPRESIVOS →

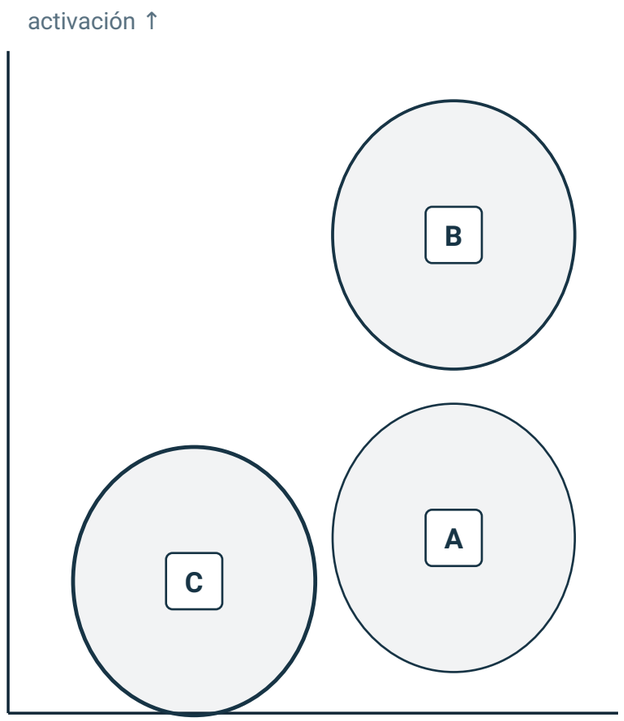
Fuera del plano

Persistencia, bipolaridad y psicosis requieren historia y criterios propios.
E/I · Judd registra los mismos niveles semanales de gravedad (sindrómico, menor, subsindrómico) en depresión unipolar (P02), bipolar I (P12) y bipolar II (P13): sostiene el solapamiento de rangos, no su equivalencia clínica.

La identidad se conserva al cambiar de plano

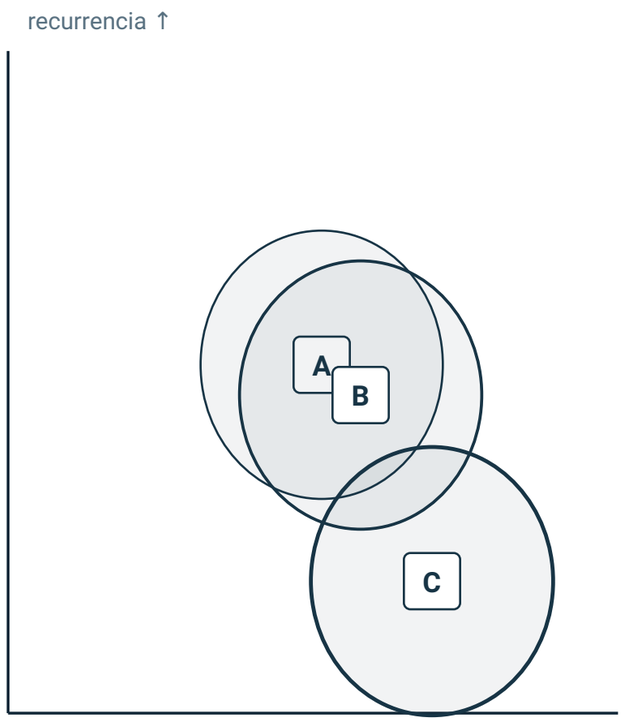
G · A = episodio inhibido · B = episodio activado · C = síntomas residuales. Ejemplos hipotéticos, no clases empíricas.

Síntomas



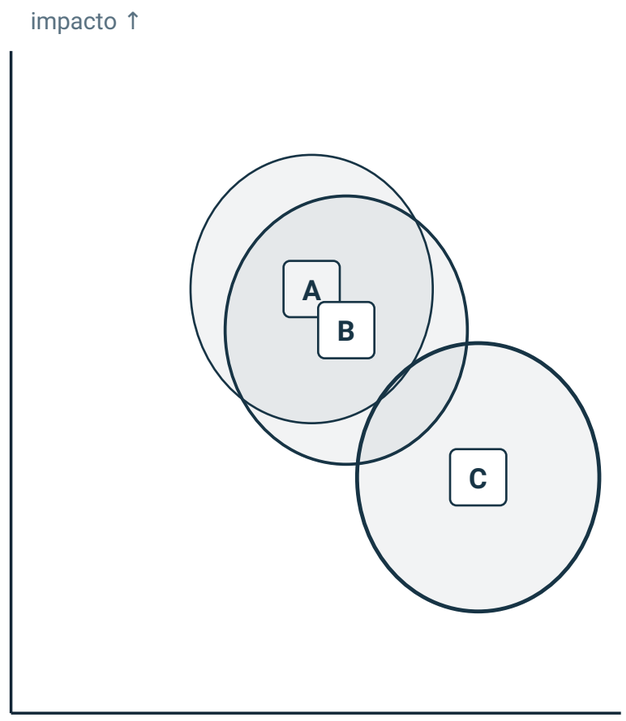
A y B comparten depresión; difieren en activación.

Curso



A y B se solapan; C ilustra residuo persistente.

Consecuencias



A y B comparten impacto; C conserva carga residual.

I · Qué permite la comparación

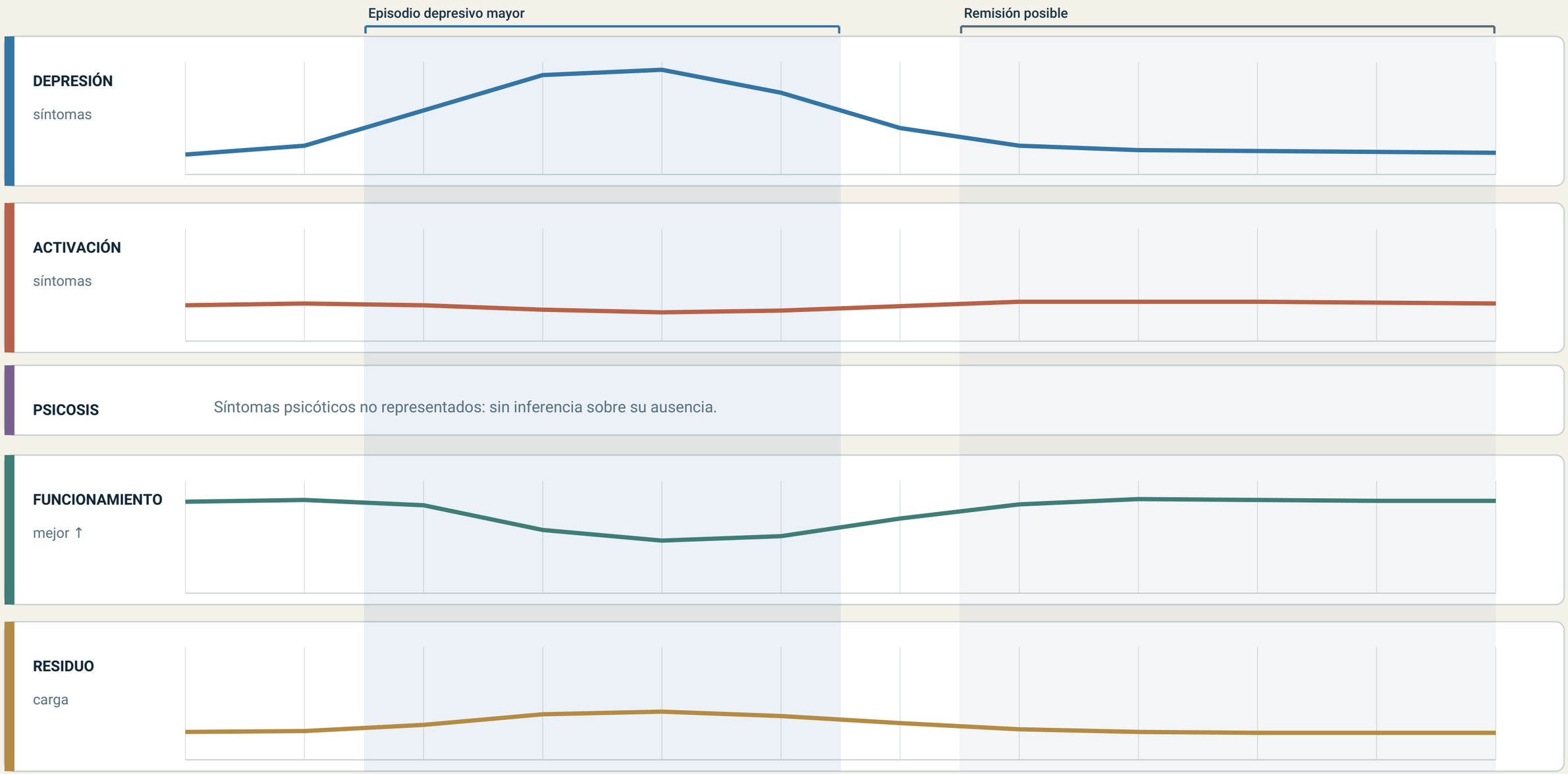
Un mismo perfil puede parecer próximo a otro en un plano y distinto en otro. La geometría no establece taxones, probabilidades, gravedad relativa o validez diagnóstica.

Los contornos conservan letra y estilo. Opacidad y tamaño facilitan lectura; no representan densidad ni dispersión medidas.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 01 · Episodio depresivo único

Un episodio puede remitir por completo o dejar síntomas residuales; no se infiere recurrencia.

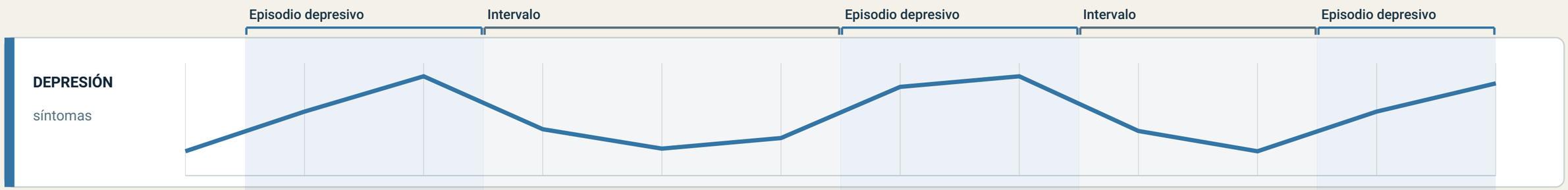


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

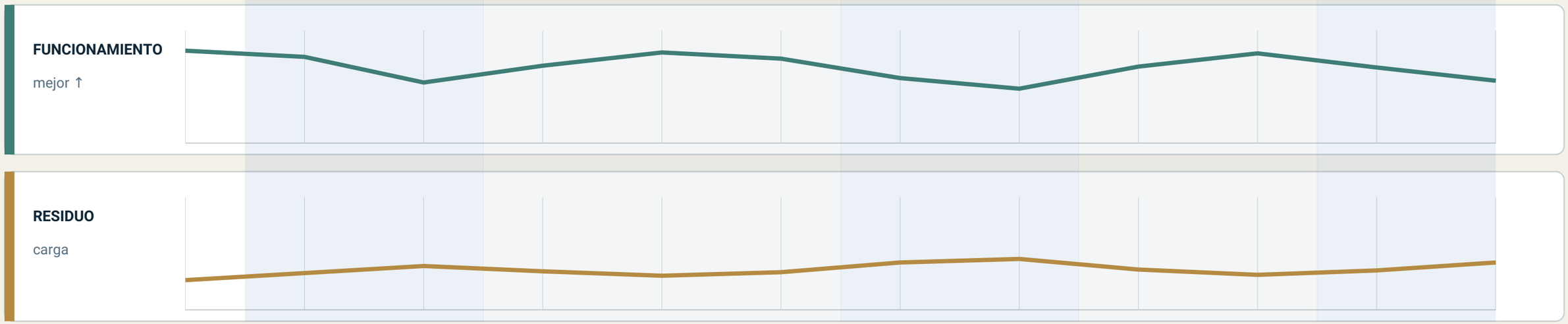
G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 02 · Depresión recurrente

Recurrencia DSM: al menos dos meses consecutivos entre episodios sin cumplir criterios de episodio mayor (N4).



PSICOSIS Síntomas psicóticos no representados: sin inferencia sobre su ausencia.



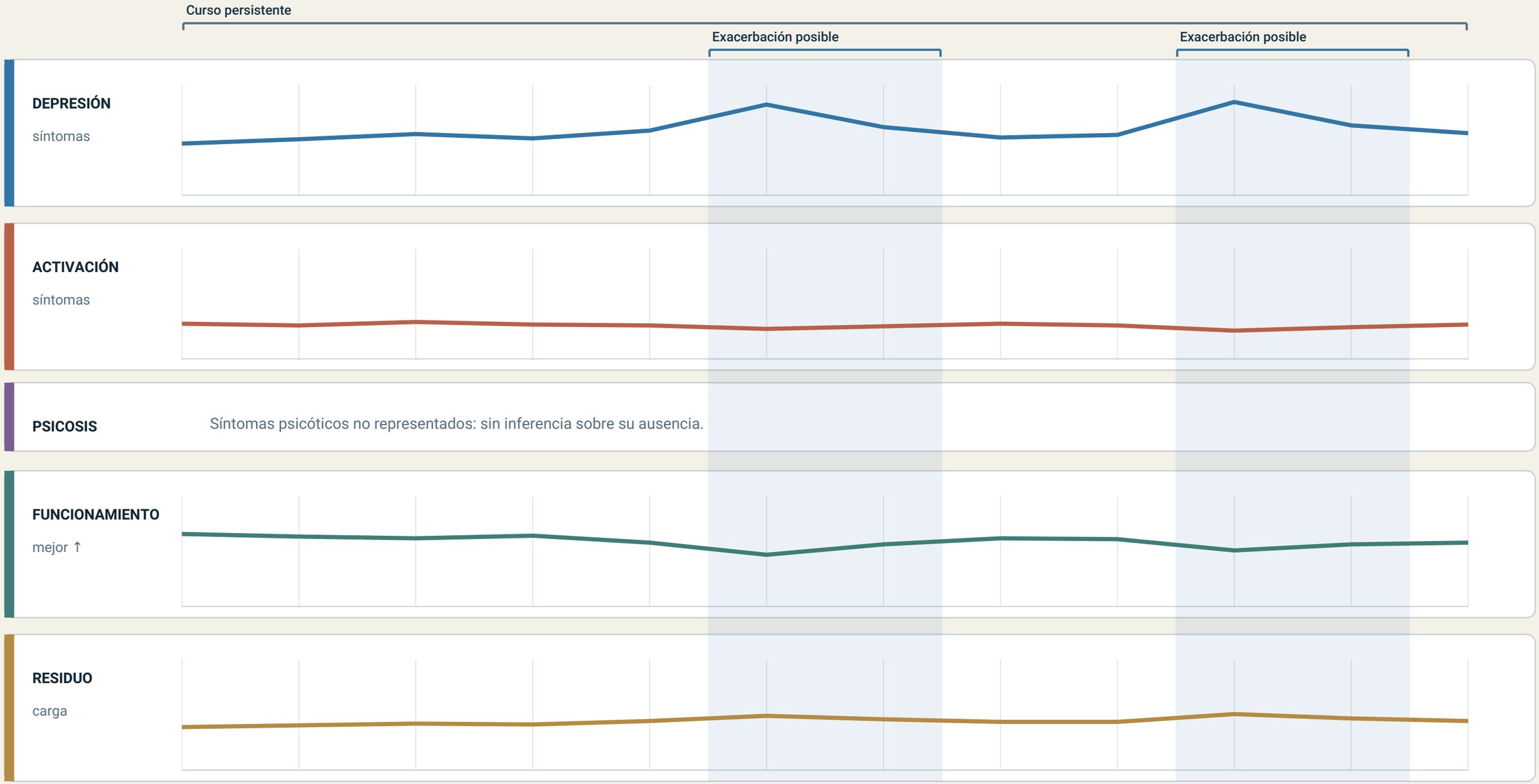
TIEMPO RELATIVO →

G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 03 · Depresión persistente

La persistencia del ánimo depresivo puede coexistir con episodios mayores superpuestos.

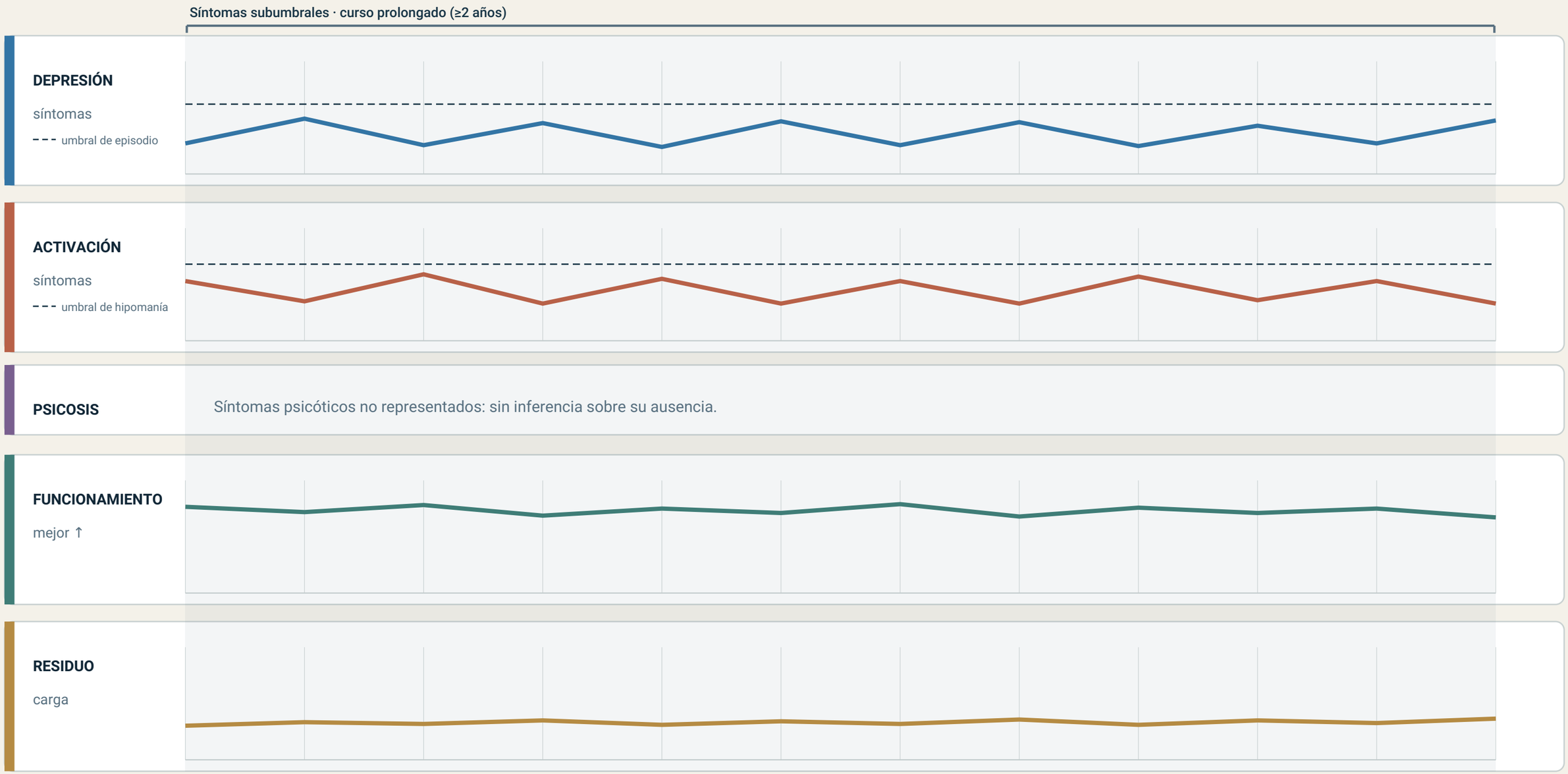


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 04 · Ciclotimia DSM

DSM: ≥2 años en adultos, síntomas ≥mitad del tiempo y sin intervalos libres >2 meses; malestar o deterioro (N6).

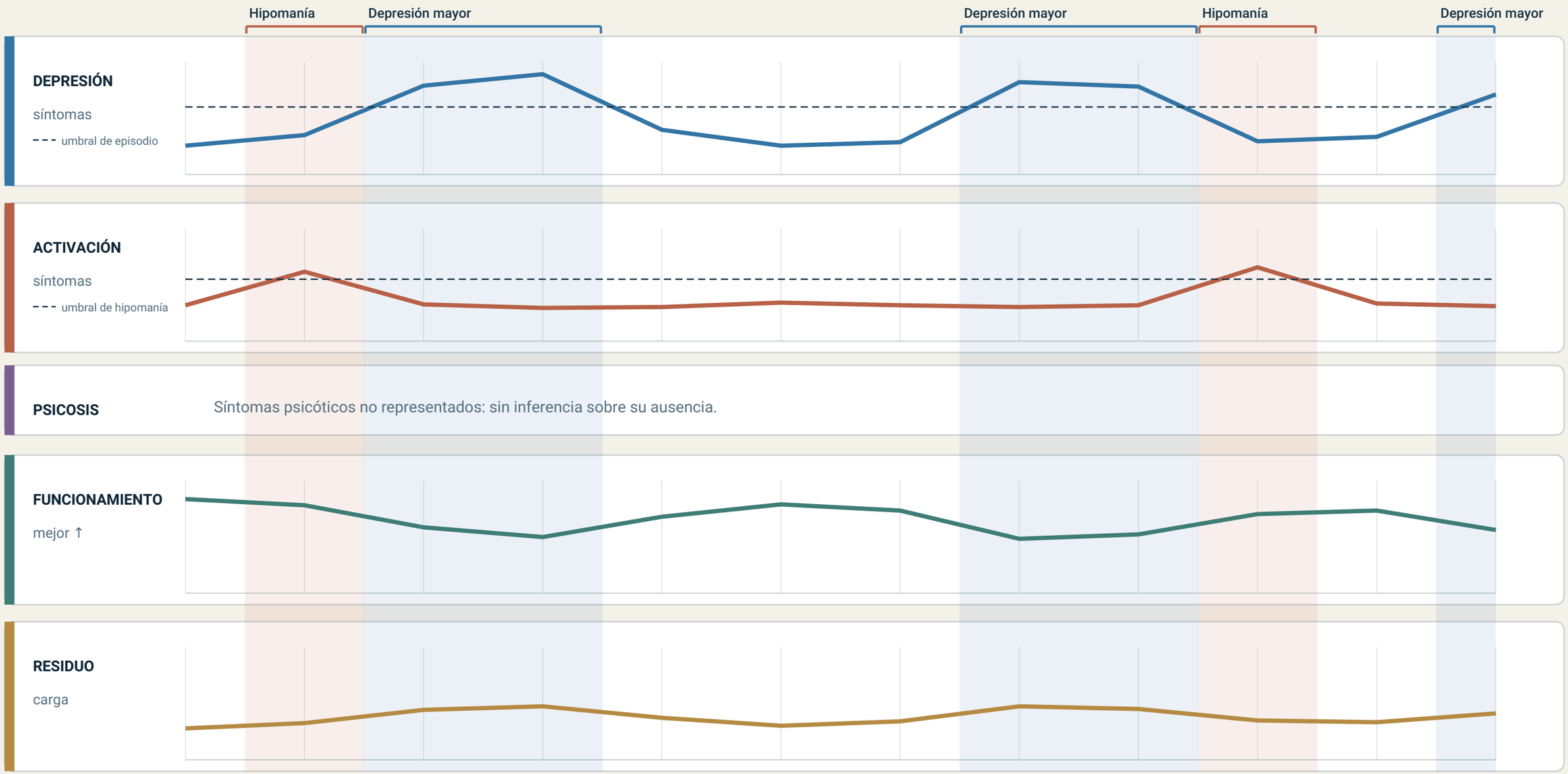


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 05 · Bipolar II

Al menos una hipomanía y una depresión mayor; la hipomanía no incluye psicosis.

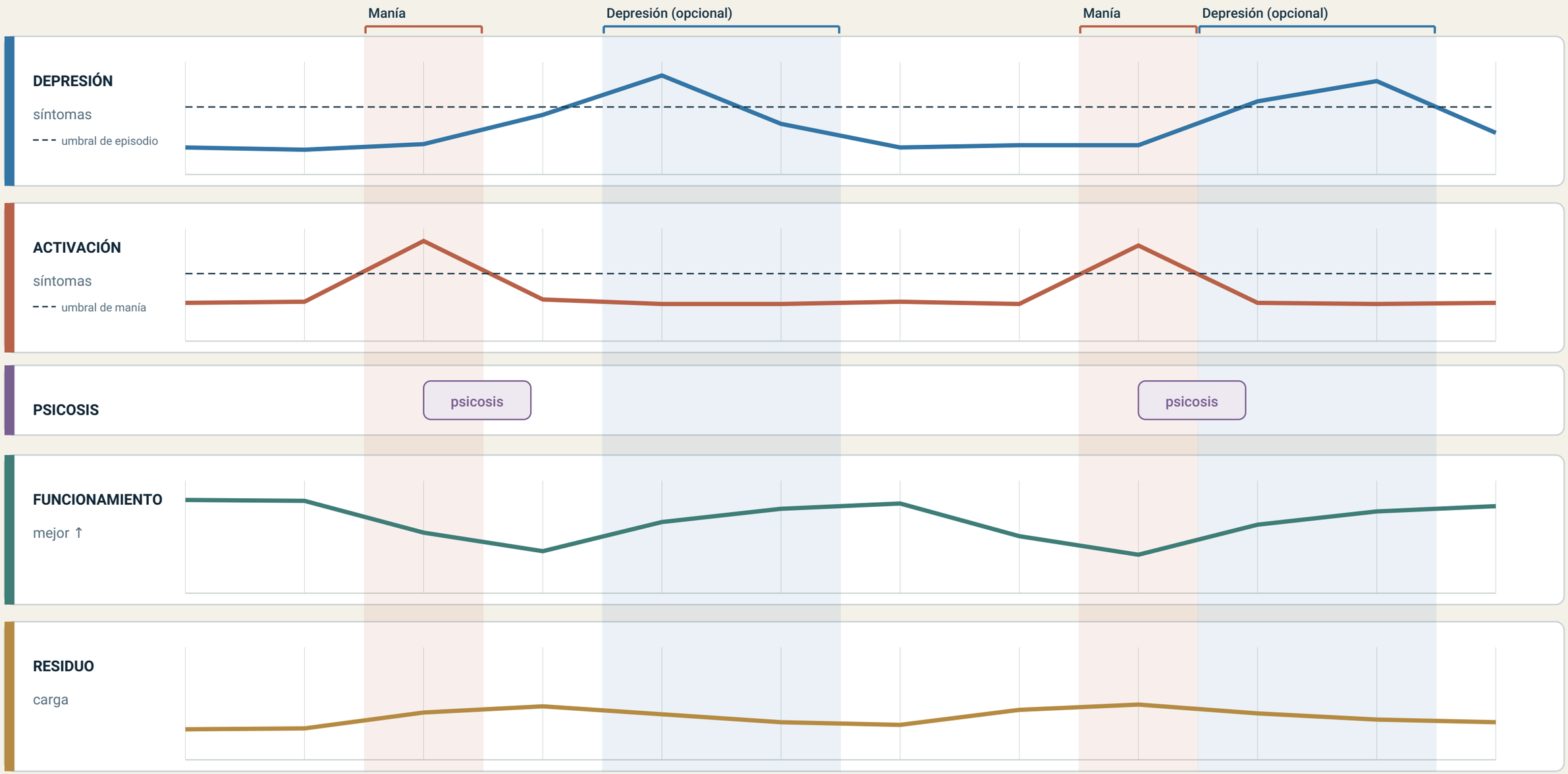


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 06 · Bipolar I

Una manía basta para el diagnóstico; pueden darse episodios depresivos, pero no se exigen.

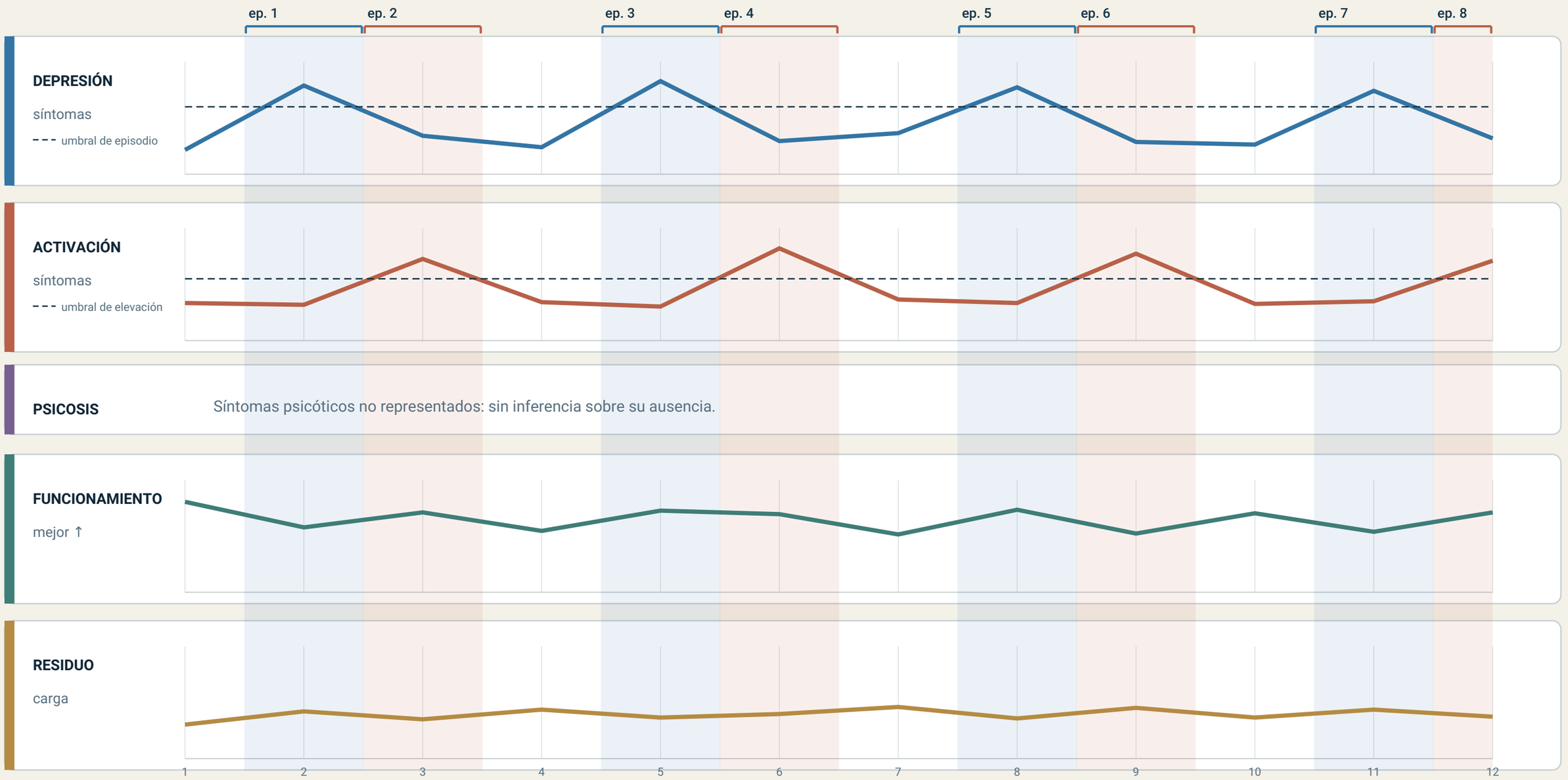


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 07 · Ciclación rápida

DSM: ≥4 episodios umbral en 12 meses; separar por remisión o cambio de polaridad. Viñeta de ejemplo, no patrón típico.



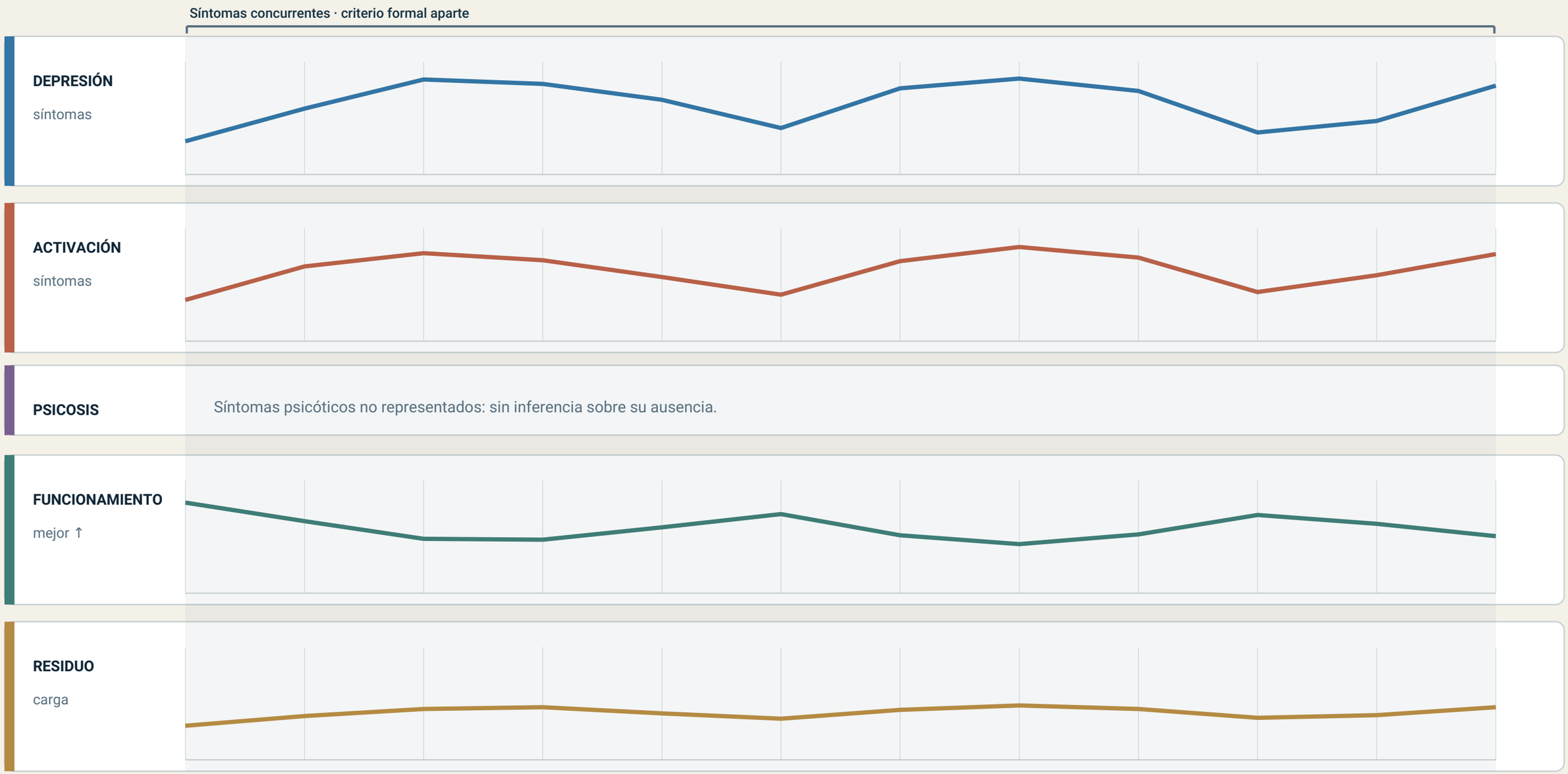
NOTAS ≥4 episodios / 12 meses No son cambios horarios MESES 01–12 →

G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 08 · Mixticidad predominante

Constructo fenomenológico: activación y síntomas depresivos coocurren. Aplicar el especificador formal solo si se cumplen sus criterios.

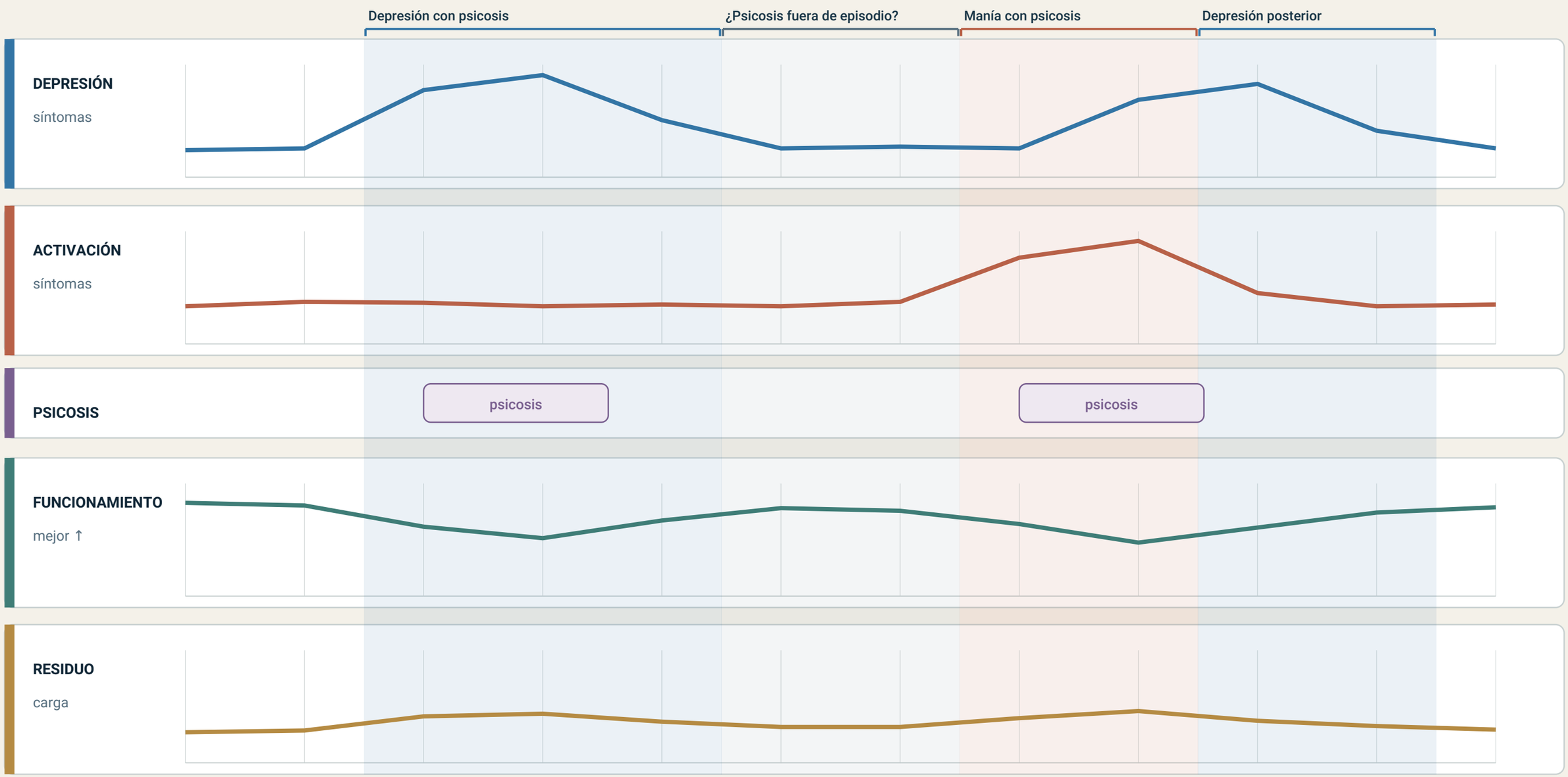


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 09 · Dimensión psicótica episódica

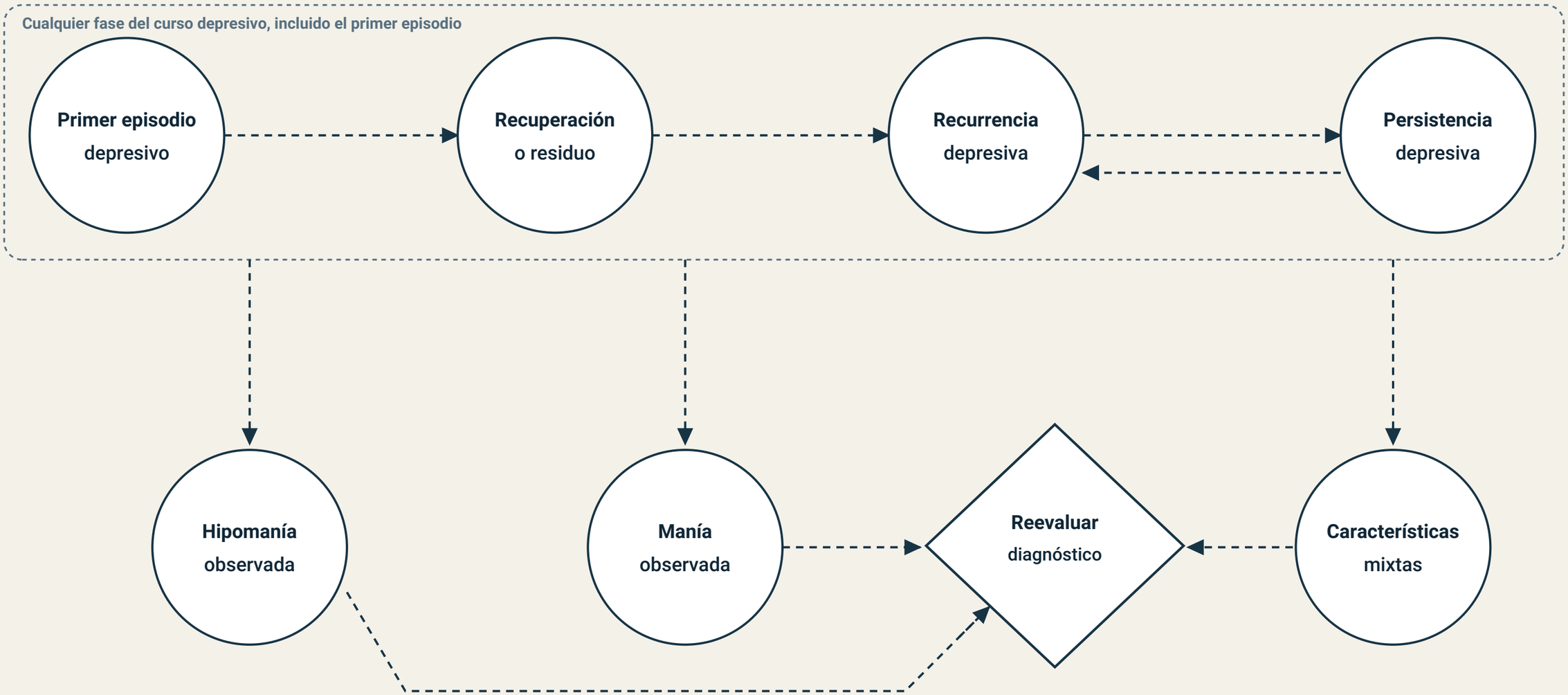
Los síntomas psicóticos se anotan respecto del episodio y su temporalidad; no son un polo adicional.



G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

I/G · relaciones clínicas posibles | evidencia de seguimiento P14; sin tasas trasladadas al gráfico

Transiciones y revisión diagnóstica



I · Los caminos son clínicos; las probabilidades no se han estimado

Círculo = estado o fenómeno observado. Rombo = acto de evaluación. El recuadro discontinuo agrupa cualquier fase del curso depresivo, incluido el primer episodio: desde él puede observarse hipomanía, manía o características mixtas, sin recurrencias intermedias. Los síntomas mixtos aislados no bastan para reclasificar como bipolar. La persistencia puede incluir episodios mayores superpuestos.

E · Fiedorowicz et al. (P14): asociación prospectiva con síntomas hipomaníacos iniciales; muchas conversiones no los presentaban. No se traslada una tasa de cohorte al individuo.
E · Angst et al. (P18): en una cohorte hospitalaria, cada nuevo episodio depresivo conlleva un riesgo de manía a lo largo de la vida; aquí se dibuja como camino posible, no como probabilidad.

Moduladores y tratamiento: capa separada

Sueño y ritmos

Desfase circadiano, privación de sueño, recuperación

Sustancias y enfermedad

Intoxicación, abstinencia, causas médicas

Tratamientos

Exposición, respuesta, efectos adversos, posible activación

Contexto

Estrés, apoyo, trauma, acontecimientos, funcionamiento

Fármacos: preguntas clínicas, no vectores causales fijos

Antidepresivos	Indicación y polaridad; vigilar activación y atribución temporal.
Estabilizadores / antipsicóticos	Evidencia dependiente de fase, molécula, formulación y desenlace.
Litio, lamotrigina, etc.	No reducir efecto clínico a afinidad receptorial o a “dirección” en el plano.

Ki ≠ ocupación ≠ respuesta clínica. Las guías terapéuticas se consultan por fase y situación individual; este atlas no ofrece una pauta de prescripción.

Ampliación: riesgo suicida p. 28 · antidepresivos y viraje p. 31 · periparto pp. 32–33 · causas médicas y sustancias pp. 36–37.

Auditoría de los originales disponibles

“Historia natural probabilística”	Sin datos calibrados, las flechas pasan a ser relaciones posibles y no probabilidades.
“Bipolar I = manía + depresión”	Se corrige: basta al menos un episodio maníaco; la depresión mayor puede faltar.
Hipomanía y psicosis en la misma elevación	Se distingue manía con psicosis de hipomanía. La psicosis depresiva se codifica por separado.
Mixticidad / ciclación como filas diagnósticas	Se representan como especificador o constructo transversal, según el sistema y el contexto.
Un único eje “depresión ↔ manía”	Se separan síntomas depresivos y activación; ambos pueden coexistir.
Trazos y sombras con aparente medición	Se retiran escalas numéricas implícitas y se declara geometría editorial no calibrada.
“Vectores” farmacológicos universales	Se reemplazan por preguntas sobre fase, evidencia, tiempo y efectos; sin causalidad mecanicista gráfica.

Alcance de la auditoría: un SVG recuperado (con tres paneles raster incrustados) y nueve PNG longitudinales. El SVG “Sistema_integrador_espectro_afectivo_v2.svg” y ocho imágenes mencionadas no estaban accesibles en el hilo al iniciar esta edición.

Precisiones temporales y terminológicas

Depresión persistente · N2

La ficha APA confirma ≥2 años de ánimo deprimido en adultos y explica por qué se elimina “distimia” del nombre. También retira especificadores inaplicables. No se equipara con depresión leve.

Ciclotimia · N3 / N6

DSM-5-TR: síntomas subumbrales, ≥2 años y al menos la mitad del tiempo; sin intervalos libres >2 meses (N6). ICD-11 permite hipomanía umbral y aplica reglas propias (N3, p. 240).

Remisión y residuo

La matriz resume el episodio índice y la historia. Remisión completa describe el estado de seguimiento; “residuo” se usa como descripción clínica, sin asignar automáticamente un código de remisión parcial.

Con características mixtas · P17

En la depresión, el recuento DSM emplea síntomas contrapolares seleccionados; irritabilidad, distractibilidad y agitación no bastan para ese recuento. No se intercambia con el constructo amplio de Koukopoulos.

En la matriz, los síntomas contrapolares del recuento DSM (activación subjetiva, menor necesidad de sueño, pensamiento acelerado) figuran como V; la agitación se muestra solo como rasgo descriptivo (N4).

Nombres y sistemas

Fila 22: DSM = manía con características mixtas; ICD-11 = episodio mixto. “Anxious distress” se conserva en inglés con traducción descriptiva: malestar ansioso; no se certifica una traducción oficial española.

Reactividad del ánimo: R en atípica (fila 11, conservada). En melancólica (fila 10) figura como V porque el criterio A se cumple con anhedonia generalizada o con ausencia de reactividad (N4).

Dos meses no significan lo mismo

Separación depresiva, remisión y continuidad ciclotímica son reglas distintas. CDDR (p. 235) admite episodios breves en ciclación rápida; no equivale sin más al criterio DSM. No inferirlo de un cruce gráfico.

Fuentes y alcance en p. 43. Resumen clínico propio: el CDDR y los criterios DSM se cotejan por separado; la reproducción gubernamental no sustituye la edición española oficial.

El espectro: cuatro propuestas y sus límites

Akiskal · P06

Amplía la clínica bipolar mediante temperamentos y formas de expresión atenuadas.

H: taxonomía de espectro; no implica que cada perfil sea un diagnóstico formal.

Ghaemi · P07

Recupera una lectura amplia de la enfermedad maníaco-depresiva y discute el corte unipolar/bipolar.

H: marco histórico y nosológico; no prueba una única dimensión biológica.

Angst y Gamma · P08

Exploran umbrales de hipomanía más amplios y síntomas subumbrales.

E/H: la prevalencia y composición cambian con la definición; no valida cualquier ampliación.

Koukopoulos · P09–10

Centra la depresión mixta en excitación, agitación y otros signos clínicos.

H: constructo con validación limitada; no equivalente al especificador DSM.

E · Evidencia longitudinal y límite inferencial

Judd: síntomas depresivos y subsindrómicos predominan en las cohortes de bipolar I y II (P12–13); esto informa sobre tiempo sintomático, no sobre altura de picos. Henry (P05): validación dimensional en 141 pacientes dentro de un ensayo abierto con olanzapina; describe activación/inhibición como un eje y un componente emocional aparte, por lo que no sostiene por sí sola la independencia de depresión y activación (P04 sí separa la activación de la valencia emocional). La estructura factorial no calibra este atlas ni establece una continuidad causal única.

I · Las viñetas bipolares se han hecho menos simétricas; no son una reconstrucción de las semanas de Judd ni un patrón universal de enfermedad.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 10 · Exposición, síntomas y reevaluación

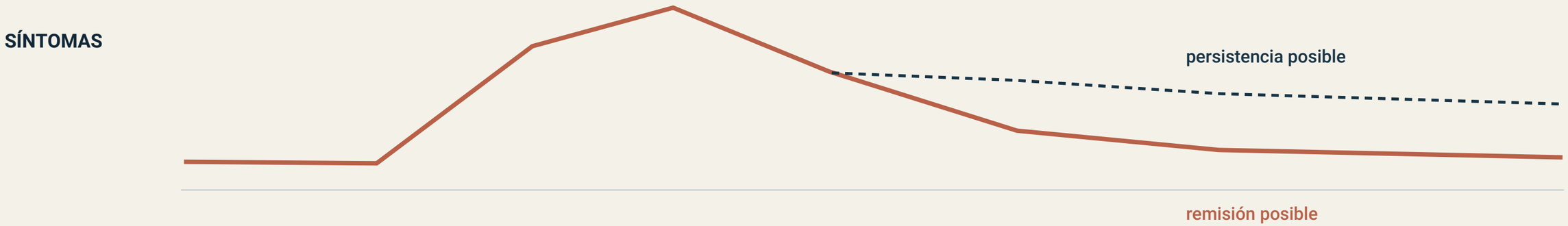
Una asociación temporal orienta la atribución; la secuencia por sí sola no demuestra causalidad.

Antes
historia basal

Exposición
sustancia / medicamento

Retirada
intoxicación / abstinencia

Seguimiento
persistencia o remisión



I · Preguntas de atribución
Qué se consumió, cuándo y por qué vía; cambios de medicación; sueño; síntomas previos; síntomas en abstinencias documentadas; causas médicas; observación de terceros. Estimulantes, catinonas y GHB exigen cronología específica, no una regla común de duración.

F / I · Separar síndrome y causa
Distinguir trastorno inducido, trastorno primario y otra afección médica. Un síndrome hipomaníaco o maníaco completo que persiste más allá del efecto del antidepresivo tiene relevancia diagnóstica; uno o dos signos de activación no bastan (N4).

I · Sin umbral universal de un mes
El plazo aproximado usado en algunas descripciones diagnósticas no es un reloj causal aplicable a cualquier sustancia. Considerar farmacología, intoxicación, abstinencia, exposición repetida y curso previo. Agitación, acatisia, TDAH, labilidad y delirium forman parte del diferencial.

Riesgo suicida y seguridad se evalúan de forma independiente en toda fase. Curvas sin unidades, dosis ni tiempos de eliminación asignados.
Ampliación: antidepresivos y viraje p. 31 · lámina 13 (activación asociada al tratamiento) p. 35 · sustancias emergentes p. 37.

Psicosis, catatonía y contexto perinatal

F · Psicosis y trastorno esquizoafectivo

Registrar si la psicosis está limitada a episodios afectivos o si también aparece fuera de ellos. El diagnóstico esquizoafectivo usa relaciones temporales distintas en DSM e ICD; no se obtiene añadiendo “psicosis” a una depresión o una manía. CDDR: sección 6A21, pp. 170–176 (N3); comparación de sistemas P17.

F / I · Catatonía

Explorar signos motores, conductuales y de respuesta al entorno mediante evaluación específica. Puede acompañar trastornos afectivos y otras condiciones; no equivale a enlentecimiento depresivo. CDDR: catatonía, pp. 201–207 (N3).

F / I · Periparto

Registrar relación temporal con embarazo y posparto, historia afectiva, sueño y síntomas psicóticos. La ventana formal depende del sistema; la vigilancia clínica no se limita a una casilla temporal. No se equiparan inicio periparto y cualquier episodio durante la maternidad.

I · La vivencia se recoge sin convertirla en biomarcador

El tiempo vivido, la pérdida de resonancia afectiva, el cuerpo, la intersubjetividad y el sentido del futuro pueden enriquecer la descripción clínica. Esta edición los conserva como preguntas abiertas de entrevista; no añade una escala fenomenológica ni interpreta sus respuestas como evidencia de bipolaridad. Una ampliación teórica de esa capa requeriría un marco y bibliografía propios.

Las capas transversales no son una escala de gravedad. El deterioro funcional puede fluctuar y recuperarse; la psicosis requiere atribución y evaluación propias.
Ampliación: periparto, ventana y riesgo pp. 32–33 · diferenciales y comorbilidad p. 38.

Cribado de bipolaridad: qué detecta cada instrumento

Los cribados orientan la entrevista; no diagnostican ni asignan un perfil de la matriz.

MDQ

Mood Disorder Questionnaire

P19

EVIDENCIA ATRIBUIDA

Autoinforme breve de cribado del espectro bipolar (bipolar I, II y no especificado). Se validó en 198 pacientes de cinco clínicas ambulatorias de trastornos del ánimo, con una entrevista telefónica ciega a la puntuación (módulo bipolar del SCID-IV): con 7 o más ítems, sensibilidad 0,73 y especificidad 0,90.

LÍMITE Y USO

E · El estudio concluye que es útil en población psiquiátrica ambulatoria. I · Su rendimiento en otros ámbitos requiere evidencia propia.

HCL-32

Hypomania Checklist de 32 ítems

P20

EVIDENCIA ATRIBUIDA

Lista autoaplicada de síntomas hipomaníacos. En 266 pacientes bipolares frente a 160 con depresión mayor (muestras de Italia y Suecia) mostró dos factores, «activo/elevado» y «asunción de riesgos/irritable», y distinguió bipolar de depresión mayor con sensibilidad del 80 % y especificidad del 51 %.

LÍMITE Y USO

E · Sensible para síntomas hipomaníacos, pero con especificidad baja; no distingue bipolar I de bipolar II. I · Sirve para abrir la anamnesis de hipomanía, no para clasificar.

BSDS

Bipolar Spectrum Diagnostic Scale

P21

EVIDENCIA ATRIBUIDA

Autoinforme basado en un relato descriptivo de rasgos bipolares sutiles (creado por Ronald Pies). En 68 pacientes bipolares y 27 con depresión mayor unipolar: sensibilidad 0,76 (0,75 en bipolar I y 0,79 en bipolar II/NOS); identificó como no bipolares al 85 % de los unipolares. Con un umbral modificado, la especificidad pasó de 0,85 a 0,93 sin pérdida significativa de sensibilidad.

LÍMITE Y USO

E · Muestra pequeña y clínica; el umbral modificado procede del mismo estudio. I · Requiere replicación antes de usarlo como criterio.

I · Un cribado positivo no es un diagnóstico

Un cribado positivo justifica evaluar los marcadores de bipolaridad (p. 30) y la historia de hipomanía (p. 19); un cribado negativo no excluye, porque las sensibilidades son inferiores a 1. Los umbrales proceden de muestras clínicas concretas.

Escalas de gravedad y de temperamento

Miden intensidad o rasgo, no polaridad ni temporalidad: esas se establecen en la entrevista.

YMRS · escala de manía

P22

Escala de 11 ítems administrada por el clínico (el artículo la presenta como «Mania Rating Scale»). Fiabilidad interevaluador de 0,93 para la puntuación total; correlacionó con una valoración global independiente y con otras dos escalas de manía, y distinguió antes y después de dos semanas de tratamiento.

I · Mide manía; no mide depresión ni mixticidad.

MADRS · gravedad depresiva

P23

Diez ítems elegidos entre los 17 síntomas más frecuentes de la depresión primaria por su cambio con el tratamiento. Correlacionó con la escala de Hamilton y diferenció respondedores de no respondedores mejor que ella.

I · Mide gravedad; no discrimina polaridad.

HAM-D · referencia histórica

P25

Hamilton (1960): escala clínica de valoración de la depresión, de la que derivan las versiones posteriores (en P24 se comparan las de 17 y 24 ítems).

PubMed no ofrece resumen del artículo original, por lo que aquí no se atribuyen datos psicométricos.

QIDS-SR16 · autoinforme

P24

Versión de 16 ítems derivada del IDS de 30 ítems. En 596 adultos ambulatorios con depresión mayor crónica no psicótica: alfa de Cronbach 0,86; correlación de 0,96 con el IDS-SR30 y de 0,86 con la HAM-D de 24 ítems; igual de sensible al cambio que ambas.

PHQ-9 · gravedad depresiva

P26

Nueve ítems (criterios DSM-IV) puntuados de 0 a 3, en 6.000 pacientes de atención primaria y de ginecología-obstetricia. Con una puntuación ≥10: sensibilidad y especificidad del 88 % para depresión mayor; los cortes 5, 10, 15 y 20 equivalen a depresión leve, moderada, moderadamente grave y grave.

I · No evalúa polaridad: una puntuación alta no distingue depresión unipolar de bipolar.

TEMPS-A corto · temperamento

P28

510 voluntarios (284 con trastornos del ánimo, 131 familiares de probandos bipolares y 95 controles): 39 de los 110 ítems originales se agrupan en cinco factores —ciclotímico, depresivo, irritable, hipertímico y ansioso—, con alfa de 0,91 a 0,67.

I · Mide temperamento, no trastorno (p. 39).

I · Las escalas cuantifican

Polaridad, temporalidad y atribución se establecen en la entrevista. Ninguna puntuación se traslada a la geometría del atlas (G).

Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase

Capa transversal: aparece en todas las matrices y láminas como recordatorio, no como variable de un perfil.

Depresión · factores asociados a suicidio

P29

Revisión sistemática con metaanálisis (19 estudios, 28 publicaciones). Asociados a suicidio: sexo masculino (OR 1,76), antecedentes familiares de trastorno psiquiátrico (1,41), intento previo (4,84), mayor gravedad de la depresión (2,20), desesperanza (2,20), ansiedad comórbida (1,59) y abuso de alcohol o drogas (2,17).

Limitaciones señaladas: pocos estudios; no se examinó la interdependencia entre factores.

Bipolar · correlatos de intentos y de muertes

P30

Metaanálisis del grupo de trabajo de la ISBD. Asociados a intentos: sexo femenino, inicio más temprano, polaridad depresiva del primer episodio y del actual o más reciente, ansiedad comórbida, cualquier trastorno por uso de sustancias, trastorno por uso de alcohol, cualquier consumo de sustancias ilícitas, trastorno de personalidad del grupo B/límite y antecedente familiar de suicidio. Asociados a muertes: sexo masculino y antecedente familiar de suicidio.

Heterogeneidad considerable; no implica causalidad.

Mortalidad y suicidio en trastornos mentales

P31

Meta-revisión de 20 revisiones (más de 1,7 millones de pacientes y más de 250.000 muertes). Todos los trastornos aumentan la mortalidad por todas las causas. El trastorno límite de la personalidad, la anorexia nerviosa, la depresión y el trastorno bipolar presentan los mayores riesgos de suicidio. La calidad de las revisiones era, en general, baja.

Mixticidad e intentos de suicidio previos

P35

En BRIDGE-II-MIX (2.811 episodios depresivos mayores), el estado mixto depresivo definido por criterios de investigación se asoció, entre otras variables, con intentos de suicidio a lo largo de la vida. La definición DSM-5 identificó el 7,5 % de los casos y la de investigación el 29,1 % (p. 29).

Instrumentos y límites de la predicción

P27 · P32

C-SSRS (P27): cuantifica la ideación y la conducta suicidas. En tres estudios multicéntricos (124 adolescentes con intento, 312 adolescentes deprimidos y 237 adultos en urgencias psiquiátricas) mostró buena validez convergente, y la ideación más grave (intención o plan) elevó las probabilidades de intento durante el estudio.

Carter et al. (P32): en un metaanálisis de valores predictivos positivos de escalas de riesgo, el VPP agrupado fue del 5,5 % para suicidio y del 26,3 % para autolesión; los autores concluyen que ninguna clasificación de «alto riesgo» fue clínicamente útil.

I · Qué hace y qué no hace el atlas

No asigna riesgo a ningún perfil: se evalúa en todos (matrices pp. 4–6 y láminas pp. 10–18). Los factores de P29–P31 orientan la exploración; ninguna escala predice el suicidio individual (P32).

Mixticidad: cuatro definiciones, cuatro conjuntos de casos

La misma depresión con síntomas contrapolares entra o no en el constructo según la definición empleada.

DSM-5-TR · especificador «con características mixtas»

F

Síntomas contrapolares seleccionados; en la depresión, la irritabilidad, la distractibilidad y la agitación no bastan para el recuento (p. 22). En BRIDGE-II-MIX lo cumplió el 7,5 % de los episodios depresivos mayores (P35).

ICD-11 · episodio mixto

F

Reconocido en bipolar I (p. 3). La comparación sistemática de ICD-11 y DSM-5 por categorías figura en P17.

Koukopoulos · depresión mixta

H

Síndrome de larga duración con ánimo disfórico, labilidad emocional, agitación psíquica o motora, locuacidad, pensamientos apiñados o acelerados, rumiación e insomnio inicial o medio (P10). Validación limitada (P10). Los autores sostienen que los criterios DSM-5 llevarían a más errores diagnósticos (P33, editorial).

Criterios de investigación (RBDC)

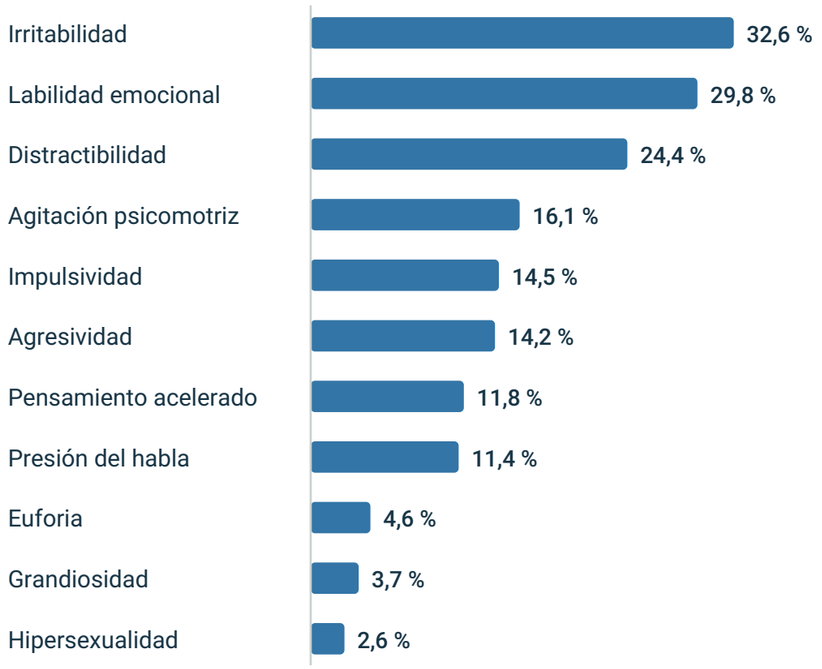
E · H

Criterios de investigación definidos a priori a partir de síntomas, curso de la enfermedad y antecedentes familiares: los cumplió el 29,1 % de los episodios depresivos mayores (cuatro veces más que con DSM-5) y se asociaron con más variables propias de la bipolaridad (P35). En un análisis posterior, el criterio DSM-5 de al menos tres síntomas se asoció con mayor gravedad aguda y deterioro, con independencia del diagnóstico unipolar o bipolar, y las definiciones menos restrictivas no mostraron esa asociación (P36).

I · Qué se observa

Los síntomas más frecuentes (irritabilidad, labilidad, distractibilidad, agitación) son justamente los que no cuentan para el recuento DSM de la depresión (p. 22).

Síntomas maníacos/hipomaníacos en episodios depresivos mayores (BRIDGE-II-MIX, n = 2.811; P35)



E · Porcentaje de pacientes con cada síntoma (P35).

I · Cada definición identifica una población distinta

7,5 % frente a 29,1 % en la misma muestra. Por eso el atlas mantiene la fila 13 (DSM) separada del constructo amplio (H) y no convierte una definición en otra.

Marcadores de bipolaridad en el episodio depresivo

Qué datos transversales, longitudinales y de respuesta a tratamiento se asocian con una evolución bipolar.

Transversal · BRIDGE

P34

5.635 adultos con un episodio depresivo mayor en curso: 903 (16,0 %) cumplían criterios DSM-IV-TR de bipolar y 2.647 (47,0 %) cumplían los criterios del «especificador de bipolaridad».

Con ambas definiciones se asociaron (OR > 2) el antecedente familiar de manía o hipomanía y los múltiples episodios previos. El especificador añadió estados maníacos o hipomaníacos durante el tratamiento antidepresivo, síntomas mixtos actuales y trastorno por uso de sustancias comórbido.

I · La definición amplia no es un diagnóstico: señala a quién reevaluar.

Longitudinal · P14 y P18

P14 · P18

Fiedorowicz (P14): 550 personas con depresión mayor, seguidas 17,5 años de media; el 19,6 % tuvo hipomanía o manía (12,2 % pasó a bipolar II y 7,5 % a bipolar I). Predijeron la progresión el número de síntomas hipomaníacos subumbral, la psicosis y la edad de inicio.

Angst (P18): 406 pacientes con ingresos por trastorno del ánimo, seguidos en promedio unos 20 años desde el inicio: cambio diagnóstico a bipolar I en torno al 1 % anual y a bipolar II en torno al 0,5 %; cada episodio depresivo conlleva un riesgo de manía que se mantiene constante. Muestra hospitalaria: generalización limitada.

Respuesta a antidepresivos · AIM

P37

En 1.329 pacientes con depresión mayor (BRIDGE-II-MIX), 404 tenían resistencia al tratamiento y 184, antecedente de irritabilidad y labilidad del ánimo inducidas por antidepresivos (AIM).

AIM se asoció con antecedente familiar de bipolar, resistencia previa, rasgos atípicos y mixtos, comorbilidad psiquiátrica, intentos de suicidio a lo largo de la vida e inicio más temprano; entre los síntomas, con distractibilidad, impulsividad e hipersexualidad.

H · Los autores lo interpretan como posible diátesis bipolar subyacente; estudio transversal.

Qué preguntar (I · derivado de los marcadores de P34)

- Antecedente familiar de manía o hipomanía.
- Número de episodios previos y su curso.
- Episodios de activación o euforia durante el tratamiento antidepresivo: fármaco, momento y duración.
- Síntomas contrapolares actuales y la definición con que se evalúan (p. 29).
- Trastorno por uso de sustancias y su cronología (p. 37).

I · Reevaluar, no reclasificar a ciegas

Estos marcadores justifican seguimiento y reevaluación diagnóstica (pp. 19 y 34); ninguno diagnostica bipolaridad por sí solo. Las cifras proceden de cohortes con definiciones y ámbitos distintos y no son probabilidades individuales (G).

E · P37, P38, P39 | F · regla de atribución N4 (p. 24) | I · no prescriptivo: riesgos descritos, no pautas

Antidepresivos, activación y reclasificación

Qué describen los metaanálisis y los registros sobre manía asociada a antidepresivos, y qué regla ordena la atribución.

Metaanálisis · riesgo global de manía

P39

73 informes (109 ensayos; 114.521 adultos). La manía asociada a antidepresivos fue más frecuente en bipolar que en depresión mayor, pero aumentó proporcionalmente más en depresión mayor. Los tricíclicos fueron más arriesgados que los ISRS; para otros tipos de antidepresivos los datos no fueron concluyentes. Los estabilizadores tuvieron efectos menores, probablemente confundidos por su uso preferente en pacientes propensos a la manía.

Riesgo global de manía (P39)

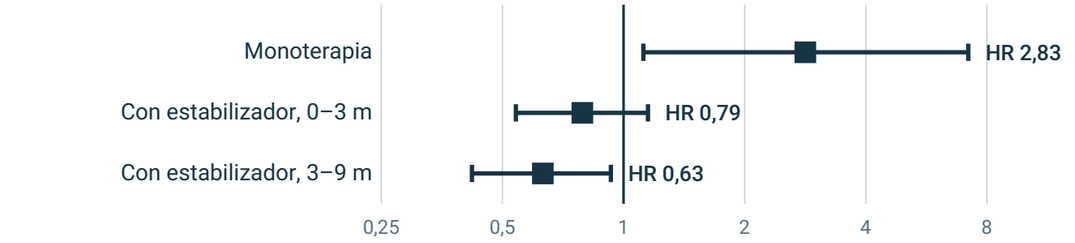


Registros suecos · antidepresivo y estabilizador

P38

3.240 pacientes bipolares que iniciaron un antidepresivo; diseño intraindividual. La monoterapia antidepresiva se asoció con más riesgo de manía; con estabilizador concurrente no hubo cambio agudo en los primeros 3 meses y el riesgo fue menor a los 3–9 meses. Los autores destacan evitar la monoterapia antidepresiva en bipolar.

Cociente de riesgo de manía (HR, IC 95 %; escala logarítmica; P38)



Atribución · regla del atlas (F · N4)

F

Un síndrome hipomaníaco o maníaco completo que persiste más allá del efecto del antidepresivo tiene relevancia diagnóstica; uno o dos signos de activación no bastan (N4; p. 24). La lámina 13 (p. 35) ilustra ambas trayectorias.

AIM y diátesis bipolar (P37)

P37

La irritabilidad y la labilidad inducidas por antidepresivos se asocian con rasgos mixtos y con una posible diátesis bipolar (p. 30). El atlas las recoge como pregunta de entrevista: exposición, respuesta, efectos adversos y posible activación (p. 20).

I · No es una pauta terapéutica

Se exponen riesgos descritos en cohortes y metaanálisis y la regla de atribución (p. 20). Los porcentajes y los cocientes de riesgo no son probabilidades individuales.

Periparto: ventana, riesgo y vigilancia

El periodo perinatal concentra riesgo de episodios graves; la lámina 11 (p. 33) lo ilustra sin calibrarlo.

Ventana y definiciones (F)

N1 · N3

DSM-5-TR: especificador «con inicio en el periparto» para episodios del estado de ánimo. ICD-11: categoría específica para los trastornos asociados al embarazo, el parto o el puerperio. Las ventanas exactas dependen del sistema y se toman del texto oficial.

La vigilancia clínica no se limita a una casilla temporal (p. 25).

Riesgo perinatal (E)

P40

Revisión en Lancet: el periodo perinatal se asocia con mayor riesgo de trastornos mentales graves; el suicidio es una de las principales causas de muerte materna. Hay pocos estudios que guíen el manejo de las mujeres con trastornos mentales graves en el embarazo y el posparto, y se subraya el análisis individual de riesgo y beneficio. Cubre bipolar, psicosis afectiva y esquizofrenia, con enfermedad crónica o con inicio de psicosis posparto.

Recaída posparto (E)

P41

Metaanálisis de 37 artículos (5.700 partos en 4.023 pacientes): riesgo global de recaída posparto del 35 % (IC 95 % 29–41). En bipolar, episodios graves posparto: 17 % (13–21); con antecedente de psicosis posparto: 29 % (20–41).

En mujeres con bipolar, la recaída fue del 66 % (57–75) si no tomaban medicación durante el embarazo y del 23 % (14–37) si recibían profilaxis; los autores concluyen que continuarla parece muy protector.

Qué registra el atlas (I)

I

Relación temporal con el embarazo y el posparto; historia afectiva previa; sueño; síntomas psicóticos y su relación con el episodio (pp. 18 y 25).

La lámina 11 (p. 33) muestra, a modo de ejemplo, una elevación con psicosis tras el parto y una depresión posterior sobre un curso bipolar previo.

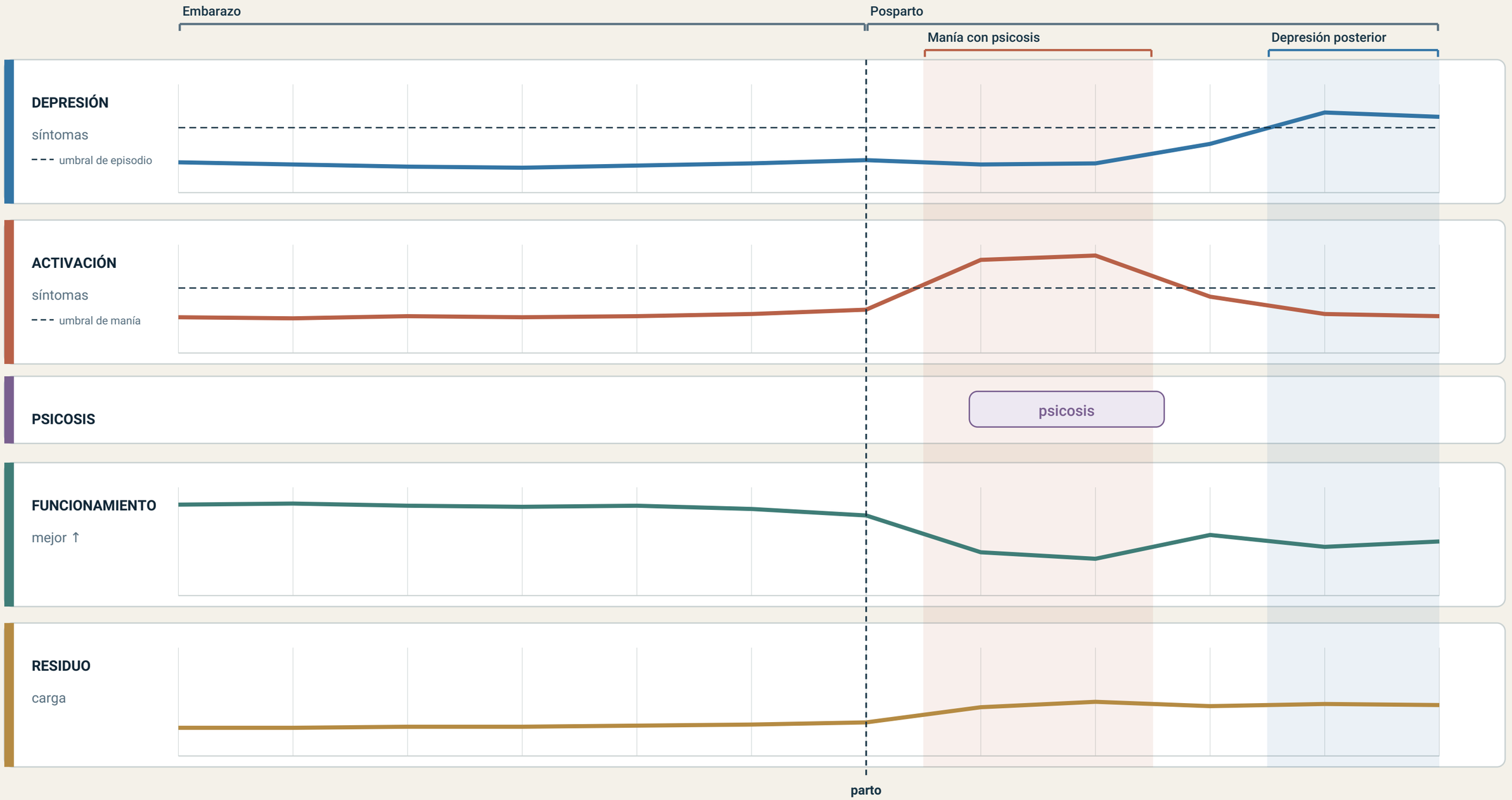
I · Límites de las cifras

Los porcentajes agrupan cohortes heterogéneas y no son probabilidades individuales; no se trasladan a la geometría de la lámina (G). Las decisiones terapéuticas perinatales requieren evaluación individual (P40).

G · viñeta ilustrativa | E · contexto perinatal P40–P41 | F · ventana: p. 32

Curso 11 · Periparto

Ejemplo: elevación con psicosis tras el parto y depresión posterior sobre un curso bipolar; la ventana formal depende del sistema (p. 32).

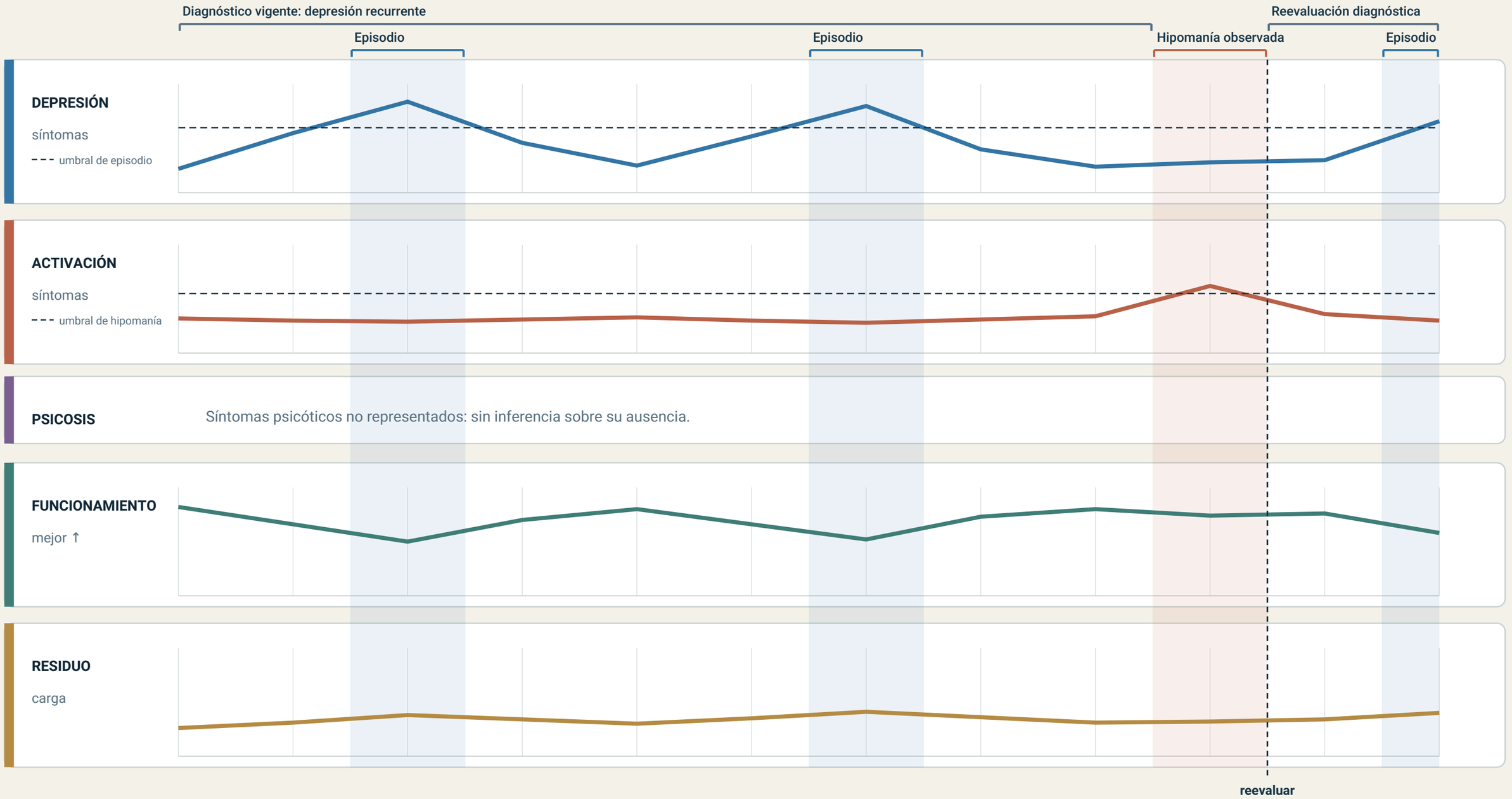


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico. La línea vertical discontinua marca el parto.

G · viñeta ilustrativa | E · P14, P18 | I · relación con pp. 19 y 30

Curso 12 · Reclasificación tras hipomanía observada

Tras una hipomanía observada puede reclasificarse un curso depresivo recurrente, si cumple criterios y no se atribuye a otra causa (p. 19).

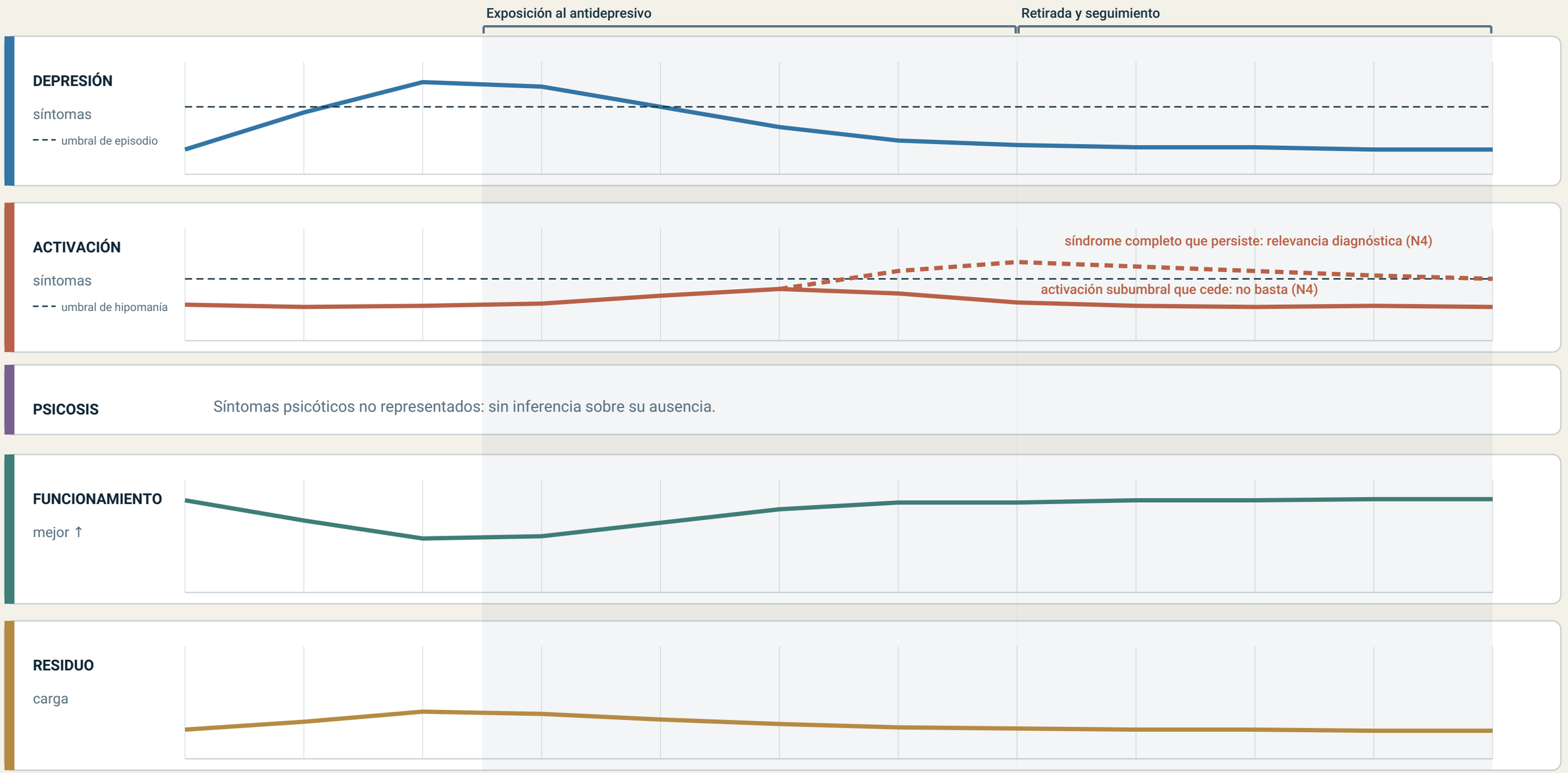


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico.

G · viñeta ilustrativa | F · regla de atribución N4 | E · P38, P39

Curso 13 · Activación asociada al tratamiento

Dos trayectorias posibles tras la exposición a un antidepresivo: activación subumbral que cede, o síndrome completo que persiste más allá del efecto fisiológico (pp. 24 y 31).



G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico. Línea de trazos gruesos: trayectoria alternativa.

Causas médicas y farmacológicas de síndromes afectivos

Un síndrome maníaco o depresivo puede ser secundario; descartarlo forma parte de leer cualquier perfil del atlas.

Manía secundaria · clásico

P42

Krauthammer y Klerman (1978): la manía puede presentarse en personas sin historia afectiva asociada a disfunción orgánica, médica y farmacológica. Se describe secundaria a fármacos, infecciones, neoplasias, epilepsia y alteraciones metabólicas.

Proponen que la manía, como la hipertensión, es un síndrome de causas múltiples y recomiendan buscar causas secundarias cuando las condiciones lo justifiquen. El registro indexa, entre otros, corticoides, isoniazida, levodopa y procarbazina.

Infección por VIH

P44

Las personas con VIH tienen mayor riesgo de enfermedad psiquiátrica: la depresión mayor y subsindrómica, la ansiedad y el abuso de sustancias son más prevalentes que en la población general.

La manía y la psicosis secundarias pueden ser el primer síntoma clínico de la demencia asociada al VIH; los autores proponen usarlas como indicador para iniciar tratamiento antirretroviral con independencia del recuento de CD4 (H). Revisión narrativa de la literatura de 1980–2008.

Preguntas que el atlas deja abiertas (I)

- ¿Hubo cambios recientes de medicación o exposición a fármacos con efecto sobre el ánimo (pp. 24 y 31)?
- ¿Existen antecedentes neurológicos, infecciosos o metabólicos, o síntomas cognitivos acompañantes?
- ¿Cómo encaja la edad y la forma de inicio con la historia afectiva previa?
- ¿El síndrome persiste tras corregir la causa sospechada?

I · Secundario no significa ajeno

Un síndrome secundario no excluye vulnerabilidad previa ni la confirma; la secuencia por sí sola no demuestra causalidad (p. 24). El VIH y la sustancia comparten escenarios clínicos con el chemsex (p. 37).

E · P45–P51 | F · atribución por cronología (p. 24) | I · no prescriptivo: fenómenos descritos para ordenar la entrevista

Sustancias emergentes, chemsex y episodios afectivos

La cronología de exposición, intoxicación y abstinencia se reconstruye por sustancia; no existe una regla común de duración.

Contexto · chemsex y salud mental

P48 · P49

Chemsex: uso de drogas antes o durante encuentros sexuales planificados; se asocian metanfetamina, GHB/GBL, mefedrona, cocaína y ketamina (revisión de 38 estudios publicados entre 2000 y 2018; los hombres con VIH participaron con más frecuencia que los VIH negativos; P48). En una revisión sistemática de 12 estudios, quienes practicaban uso sexualizado de drogas presentaron con más frecuencia depresión, ansiedad o dependencia, aunque no en todos los estudios; los síntomas fueron más graves entre quienes se inyectaban (slamsex) (P49).

SUSTANCIA	FENÓMENOS DESCRITOS (E)	CRONOLOGÍA
Metanfetamina P45	309 consumidores regulares (Sídney): 13 % con cribado positivo de psicosis y 23 % con algún síntoma clínicamente significativo (suspicacia, ideas inusuales o alucinaciones) en el último año; los dependientes tuvieron tres veces más probabilidad de haber presentado síntomas psicóticos. Prevalencia 11 veces la de la población general australiana.	Último año; estudio transversal
GHB / GBL · retirada P46 · P47	Serie de 8 pacientes tras uso crónico: todos psicóticos y con agitación intensa, con delirium y alucinaciones auditivas y visuales; dependencia tras tomas cada 1–3 horas. La revisión describe inestabilidad autonómica relativamente leve y breve con síntomas psicóticos prolongados.	Inicio 1–6 h tras la última dosis; duración 5–15 días
Cannabis P50	Revisión de 6 estudios prospectivos (2.391 personas con síntomas maníacos; seguimiento medio de 3,9 años): asociación con la exacerbación de síntomas maníacos en bipolar; en un metaanálisis de dos estudios, OR 2,97 (1,80–4,90) para el inicio de síntomas maníacos. Conclusiones preliminares.	Seguimiento medio 3,9 años
Mefedrona y catinonas P51	Efectos estimulantes y empatógenos similares a anfetamina, metanfetamina, cocaína y MDMA; por su acción simpaticomimética puede asociarse con efectos adversos físicos y psicopatológicos. Evidencia limitada: parte de la información procede de informes de usuarios.	No establecida en la revisión

I · Atribución y límites

El consumo no excluye un trastorno afectivo primario ni lo confirma; no hay un plazo universal de un mes (p. 24). Esta página no es una pauta de manejo: recoge fenómenos descritos y su cronología.

Diagnóstico diferencial y comorbilidad: preguntas clave

Un diferencial no excluye al otro: la comorbilidad es frecuente y la atribución se hace por cronología e historia.

Trastorno límite de la personalidad

P43 · P35 · P30

Coexiste con el trastorno bipolar, pero la relación no es consistente ni específica; hay solapamientos y diferencias importantes en fenomenología, respuesta a fármacos y curso; los estudios familiares sugieren distinciones claras y es inusual que evolucione a bipolar (P43). La comorbilidad con límite se asoció con el estado mixto depresivo de investigación (P35) y, en bipolar, con intentos de suicidio (P30).

I · Registrar duración, desencadenantes y curso longitudinal de los cambios de ánimo.

TDAH

P35 · P37

La distractibilidad y la impulsividad figuran entre los síntomas contrapolares frecuentes en los episodios depresivos (24,4 % y 14,5 %), y el TDAH comórbido se asoció con el estado mixto de investigación (P35); distractibilidad e impulsividad se asociaron con la irritabilidad inducida por antidepresivos (P37).

I · Preguntar por inicio en la infancia y persistencia entre episodios.

Trastornos por uso de sustancias

P30 · P45–P51

La comorbilidad con sustancias se asoció con intentos de suicidio en bipolar (P30). La cronología de la exposición orienta la atribución (pp. 24 y 37).

Causas médicas y farmacológicas

P42 · P44

Manía secundaria a drogas, infecciones, neoplasias, epilepsia y alteraciones metabólicas (P42); infección por VIH (P44). Véase p. 36.

Esquizoafectivo y psicosis primaria

F

Registrar si la psicosis se limita a episodios afectivos o aparece también fuera de ellos; el diagnóstico esquizoafectivo usa relaciones temporales distintas en DSM e ICD (p. 25).

Ansiedad comórbida y malestar ansioso

P29 · P30

La ansiedad comórbida se asoció con suicidio en depresión (OR 1,59; P29) y con intentos en bipolar (P30). La fila 09 recoge el malestar ansioso como especificador (p. 22).

I · Comorbilidad frente a diferencial

Varias de estas condiciones son a la vez diagnóstico alternativo y comorbilidad; el atlas las recoge como preguntas abiertas y no como exclusiones automáticas.

Temperamentos afectivos

Cinco factores de temperamento en el TEMPS-A corto (510 voluntarios); consistencia interna entre paréntesis.

Ciclotímico

Consistencia interna: alfa 0,91

Correlación positiva con búsqueda de novedad y, como el resto salvo el hipertímico, con evitación del daño (P28).

Correlacionó, junto con el depresivo, con el factor «depresión» de la manía (P04). Las depresiones sobre oscilaciones ciclotímicas se describen como una variante más grave de bipolar II (P06).

Depresivo

Consistencia interna: alfa 0,81

Correlación positiva con evitación del daño y negativa con búsqueda de novedad (P28).

Correlacionó con el factor «depresión» de la manía (P04).

Irritable

Consistencia interna: alfa 0,77

Correlación positiva con evitación del daño y negativa con búsqueda de novedad (P28).

Hipertímico

Consistencia interna: alfa 0,76

Rasgos hipomaníacos de por vida sin episodios hipomaníacos discretos (P06).

Correlación positiva con búsqueda de novedad, dependencia de la recompensa, persistencia y autodirección; no se correlacionó con evitación del daño (P28).

Ansioso

Consistencia interna: alfa 0,67

Escala añadida después de las otras cuatro; evaluada solo en 345 sujetos (P28).

Correlación positiva con evitación del daño y con autotrascendencia.

H · Naturaleza dual del temperamento (P28)

Los autores muestran, para cada temperamento, atributos positivos con sentido evolutivo y rasgos que hacen vulnerable a los cambios del ánimo; proponen esa dualidad como endofenotipo conductual en un modelo oligogénico de la herencia bipolar. Es una hipótesis.

I · Cómo se usa en el atlas

El temperamento se anota como pregunta abierta de entrevista, junto con la vivencia (p. 25); no es un diagnóstico, no es un eje de la matriz y no se confunde con la ciclotimia DSM (fila 15, p. 13).

Línea histórica del concepto

Del concepto amplio de Kraepelin a la separación bipolar/unipolar y al regreso del espectro.

Origen · Kraepelin

Concepto amplio de enfermedad maníaco-depresiva, con episodios de ambos polos y estados mixtos.

P07 · P10

1978–1980

Los RDC (1978) y el DSM-III (1980) operacionalizan los estados mixtos maníacos y dejan fuera las depresiones mixtas. El DSM-III divide el concepto en bipolar y unipolar, siguiendo a Leonhard.

P07 · P10

1992

Koukopoulos describe el síndrome depresivo mixto.

P10

DSM-IV / ICD-10

La manía mixta (disfórica) se incluye formalmente. La hipomanía exige ≥4 días, aunque su duración habitual sea de 1–3 días.

P06

2000–2005

Espectro bipolar de Akiskal y de Angst: umbrales de hipomanía más amplios y síntomas subumbrales. Akiskal propone representar el curso con gráficos de colores (life charting).

P06 · P08

2008

Revisión de la ciclación rápida: especificador de curso (≥4 episodios al año) sin otras características clínicas que la definan.

P11

2013

Se publica el DSM-5, con el especificador «con características mixtas»; su definición recibe críticas desde el espectro.

P17 · P33

2019–2022

La Asamblea Mundial de la Salud aprueba la ICD-11 (2019); la APA publica el DSM-5-TR en 2022.

P17 · N2

I · Una tensión que el atlas hereda

La historia muestra el vaivén entre concepto amplio y categorías; el atlas lo trata como pregunta abierta (p. 23).

Glosario bilingüe y equivalencias de términos

Para leer la bibliografía en inglés y las fichas oficiales sin perder el matiz.

TÉRMINO EN INGLÉS	TÉRMINO EN EL ATLAS	NOTA Y FUENTE
mixed features	características mixtas	Especificador DSM; p. 22 (fila 13).
mixed state / mixed episode	estado mixto / episodio mixto	ICD-11: episodio mixto en bipolar I (p. 3).
anxious distress	malestar ansioso (término inglés conservado)	Sin traducción oficial certificada (p. 22; fila 09).
melancholic features	características melancólicas	Especificador DSM (fila 10).
atypical features	características atípicas	Especificador DSM (fila 11).
with psychotic features	con características psicóticas	Fila 12; pp. 18 y 25.
seasonal pattern	patrón estacional	Fila 08.
rapid cycling	ciclación rápida	Especificador de curso: ≥4 episodios en 12 meses (p. 16).
peripartum onset	inicio en el periparto	Pp. 32 y 33.
persistent depressive disorder	trastorno depresivo persistente	DSM-5-TR retira «dysthymia» del nombre (N2).
cyclothymic disorder	trastorno ciclotímico	Fila 15; p. 13.
subthreshold	subumbral	Síntomas que no alcanzan criterios de episodio.
full / partial remission	remisión completa / parcial	«Residuo» no equivale automáticamente a remisión parcial (p. 22).
treatment-emergent mania (switch)	manía emergente con el tratamiento (viraje)	Pp. 24, 31 y 35.
antidepressant-induced irritability and mood lability (AIM)	irritabilidad y labilidad inducidas por antidepresivos	P37; p. 30.
bipolar spectrum	espectro bipolar	Akiskal, Angst y Ghaemi (P06–P08; p. 23).
bipolar III	bipolar III (denominación de espectro)	Hipomanía asociada a antidepresivos; ausente de ICD-10 y DSM-IV (P06).
agitated depression	depresión agitada	Koukopoulos (P09); p. 29.
temperament	temperamento	TEMPS-A (P28); p. 39.
life chart	cronograma vital	Representación gráfica del curso, como las láminas 01–13 (P06).

Las traducciones son descriptivas del atlas; cotejar con la edición española oficial del DSM-5-TR y con la traducción de la ICD-11.

I · orden de lectura del atlas; no es un algoritmo diagnóstico ni sustituye la entrevista

Guía de lectura de un caso

Once preguntas, en el orden en que suelen abrirse, con las páginas donde el atlas las desarrolla.

1	¿Es un episodio actual o un seguimiento?	pp. 4–6 (marco temporal) · p. 22
2	¿Hubo alguna vez hipomanía o manía observadas, y con qué calidad de observación?	p. 3 · p. 5 · p. 19 · p. 34
3	¿Qué polaridad y qué frecuencia de episodios hay? ¿Cuatro o más en 12 meses?	pp. 10–18 · p. 16
4	¿Hay síntomas contrapolares concurrentes, y según qué definición?	p. 7 · p. 8 · p. 29
5	¿Hay psicosis? ¿Solo durante los episodios afectivos?	p. 18 · p. 25
6	¿Hubo exposición a antidepresivos, otros fármacos o sustancias? ¿Con qué cronología?	pp. 24, 31, 35–37
7	¿Existe relación con el embarazo o el posparto?	pp. 32–33
8	¿Cómo se evalúa el riesgo suicida? (en todas las fases)	p. 28
9	¿Qué instrumentos pueden ayudar y qué no miden?	pp. 26–27
10	¿Qué diferenciales y comorbilidades quedan abiertas?	p. 36 · p. 38 · p. 39
11	¿Qué incertidumbre persiste y qué se reevaluará?	p. 9 · p. 19 · p. 30

I · Qué es y qué no es esta guía

Ordena la lectura del atlas. No es un algoritmo diagnóstico: las atribuciones se establecen con entrevista, duración, deterioro, exclusiones y contexto (p. 3).

Método de verificación y fuentes normativas

Alcance real de esta revisión

Se verificaron metadatos y resúmenes de 51 artículos en PubMed: título, autoría abreviada, revista, fecha, volumen, páginas y DOI. No es una revisión sistemática ni una evaluación integral de sesgos. Los resúmenes no sustituyen el texto completo; las figuras no se ajustan a sus datos.
Las cifras de las pp. 26–42 se toman de los resúmenes de PubMed (P19–P51, verificados el 3-nov-2026); P25 (Hamilton, 1960) no tiene resumen y P33 es un editorial.

N1 · APA	DSM-5-TR: actualización y cambios bipolar I/II. Fichas oficiales, no manual íntegro.	psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/updates-to-dsm/updates-to-dsm-5-tr-criteria-text · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N2 · APA	Persistent Depressive Disorder: retirada de “dysthymia” y especificadores inaplicables.	psychiatry.org/getmedia/fd3dfaad-d409-4e94-8605-0350adec5b91/APA-DSM5TR-PersistentDepressive.pdf · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N3 · OMS	CDDR 2024: cotejo selectivo directo; episodios pp. 212–224, bipolar pp. 225–243, ciclotimia p. 240.	who.int/publications/i/item/9789240077263 · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N4 · Extractos DSM-5	National Academies (2019), Selected Health Conditions: reproducción de criterios; no DSM-5-TR.	ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559511/ · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N5 · NICE	CG185: recomendaciones por fase; página accesible en búsqueda, apertura directa 403 en esta revisión.	nice.org.uk/guidance/cg185/chapter/recommendations · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N6 · VAC Canadá	Criterios derivados de DSM-5-TR: manía, hipomanía, depresión, bipolar I/II y ciclotimia; revisión 2025.	veterans.gc.ca/…/entitlement-eligibility-guidelines/az-index/bipolar-and-related-disorders · corte 28-oct-2026 · enlace activo

Cotejo: CDDR íntegro descargado de una copia del documento OMS alojada en drugsandalcohol.ie; se leyeron las secciones pertinentes, no las 852 páginas. N6 reproduce criterios derivados de DSM-5-TR. No se dispuso de todo el manual APA ni de su traducción española oficial; detalles de especificadores no cubiertos siguen sujetos a cotejo editorial.

Copia íntegra CDDR consultada: WHO 2024, ISBN 9789240077263 (enlace al PDF)

F = criterio formal resumido, con alcance de cotejo declarado; E = hallazgo empírico atribuido a su fuente; I = interpretación clínica (síntesis editorial); H = hipótesis o propuesta; G = geometría editorial no calibrada. Fuente por bloque/página.

Bibliografía verificada · 1

P01 Long-term symptomatic status of bipolar I vs. bipolar II disorders.

Lewis L Judd, Pamela J Schettler, Hagop S Akiskal et al. The international journal of neuropsychopharmacology. 2003 Jun;6(2):127-37.

DOI 10.1017/S1461145703003341 | PMID 12890306

P02 A prospective 12-year study of subsyndromal and syndromal depressive symptoms in unipolar major depressive disorders.

L L Judd, H S Akiskal, J D Maser et al. Archives of general psychiatry. 1998 Aug;55(8):694-700.

DOI 10.1001/archpsyc.55.8.694 | PMID 9707379

P03 The functional impact of subsyndromal depressive symptoms in bipolar disorder: data from STEP-BD.

Lauren B Marangell, Ellen B Dennehy, Sachiko Miyahara et al. Journal of affective disorders. 2009 Apr;114(1-3):58-67.

DOI 10.1016/j.jad.2008.07.006 | PMID 18708263

P04 Proposed multidimensional structure of mania: beyond the euphoric-dysphoric dichotomy.

H S Akiskal, J M Azorin, E G Hantouche. Journal of affective disorders. 2003 Jan;73(1-2):7-18.

DOI 10.1016/s0165-0327(02)00318-x | PMID 12507733

P05 Inhibition/activation in bipolar disorder: validation of the Multidimensional Assessment of Thymic States scale (MAThyS).

Chantal Henry, Amandine Luquiens, Christophe Lançon et al. BMC psychiatry. 2013 Mar 13;13:79.

DOI 10.1186/1471-244X-13-79 | PMID 23510483

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 2

P06 Re-evaluating the prevalence of and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders.

H S Akiskal, M L Bourgeois, J Angst et al. Journal of affective disorders. 2000 Sep;59 Suppl 1:S5-S30.

DOI 10.1016/s0165-0327(00)00203-2 | PMID 11121824

P07 Bipolar spectrum: a review of the concept and a vision for the future.

S Nassir Ghaemi. Psychiatry investigation. 2013 Sep;10(3):218-24.

DOI 10.4306/pi.2013.10.3.218 | PMID 24302943

P08 A new bipolar spectrum concept: a brief review.

Jules Angst, Alex Gamma. Bipolar disorders. 2002;4 Suppl 1:11-4.

DOI 10.1034/j.1399-5618.4.s1.1.x | PMID 12479669

P09 Mixed depressive states: nosologic and therapeutic issues.

Athanasios Koukopoulos, Matthew J Albert, Gabriele Sani et al. International review of psychiatry (Abingdon, England). 2005 Feb;17(1):21-37.

DOI 10.1080/09540260500064744 | PMID 16194768

P10 Depressive mixed states: A reappraisal of Koukopoulos' criteria.

Gianni L Faedda, Ciro Marangoni, Daniela Reginaldi. Journal of affective disorders. 2015 May 01;176:18-23.

DOI 10.1016/j.jad.2015.01.053 | PMID 25687279

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 3

P11 Rapid cycling bipolar disorder--diagnostic concepts.

Michael Bauer, Serge Beaulieu, David L Dunner et al. Bipolar disorders. 2008 Feb;10(1 Pt 2):153-62.

DOI 10.1111/j.1399-5618.2007.00560.x | PMID 18199234

P12 The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder.

Lewis L Judd, Hagop S Akiskal, Pamela J Schettler et al. Archives of general psychiatry. 2002 Jun;59(6):530-7.

DOI 10.1001/archpsyc.59.6.530 | PMID 12044195

P13 A prospective investigation of the natural history of the long-term weekly symptomatic status of bipolar II disorder.

Lewis L Judd, Hagop S Akiskal, Pamela J Schettler et al. Archives of general psychiatry. 2003 Mar;60(3):261-9.

DOI 10.1001/archpsyc.60.3.261 | PMID 12622659

P14 Subthreshold hypomanic symptoms in progression from unipolar major depression to bipolar disorder.

Jess G Fiedorowicz, Jean Endicott, Andrew C Leon et al. The American journal of psychiatry. 2011 Jan;168(1):40-8.

DOI 10.1176/appi.ajp.2010.10030328 | PMID 21078709

P15 The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 3: The Clinical Guidelines.

Konstantinos N Fountoulakis, Heinz Grunze, Eduard Vieta et al. The international journal of neuropsychopharmacology. 2017 Feb 01;20(2):180-195.

DOI 10.1093/ijnp/pyw109 | PMID 27941079

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 4

P16 Rapid cycling in bipolar disorder: a systematic review.

André F Carvalho, Dimos Dimellis, Xenia Gonda et al. The Journal of clinical psychiatry. 2014 Jun;75(6):e578-86.

DOI 10.4088/JCP.13r08905 | PMID 25004199

P17 An organization- and category-level comparison of diagnostic requirements for mental disorders in ICD-11 and DSM-5.

Michael B First, Wolfgang Gaebel, Mario Maj et al. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2021 Feb;20(1):34-51.

DOI 10.1002/wps.20825 | PMID 33432742

P18 Diagnostic conversion from depression to bipolar disorders: results of a long-term prospective study of hospital admissions.

Jules Angst, Robert Sellaro, Hans H Stassen et al. Journal of affective disorders. 2005 Feb;84(2-3):149-57.

DOI 10.1016/S0165-0327(03)00195-2 | PMID 15708412

P19 Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire.

R M Hirschfeld, J B Williams, R L Spitzer et al. The American journal of psychiatry. 2000 Nov;157(11):1873-5.

DOI 10.1176/appi.ajp.157.11.1873 | PMID 11058490

P20 The HCL-32: towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients.

Jules Angst, Rolf Adolfsson, Franco Benazzi et al. Journal of affective disorders. 2005 Oct;88(2):217-33.

DOI 10.1016/j.jad.2005.05.011 | PMID 16125784

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 5

P21 Sensitivity and specificity of a new bipolar spectrum diagnostic scale.

S Nassir Ghaemi, Christopher J Miller, Douglas A Berv et al. Journal of affective disorders. 2005 Feb;84(2-3):273-7.

DOI 10.1016/S0165-0327(03)00196-4 | PMID 15708426

P22 A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity.

R C Young, J T Biggs, V E Ziegler et al. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 1978 Nov;133:429-35.

DOI 10.1192/bjp.133.5.429 | PMID 728692

P23 A new depression scale designed to be sensitive to change.

S A Montgomery, M Asberg. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 1979 Apr;134:382-9.

DOI 10.1192/bjp.134.4.382 | PMID 444788

P24 The 16-Item Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS), clinician rating (QIDS-C), and self-report (QIDS-SR): a psychometric evaluation in patients with chronic major depression.

A John Rush, Madhukar H Trivedi, Hicham M Ibrahim et al. Biological psychiatry. 2003 Sep 1;54(5):573-83.

DOI 10.1016/s0006-3223(02)01866-8 | PMID 12946886

P25 A rating scale for depression.

M Hamilton. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 1960 Feb;23(1):56-62.

DOI 10.1136/jnnp.23.1.56 | PMID 14399272

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 6

P26 The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure.

K Kroenke, R L Spitzer, J B Williams. Journal of general internal medicine. 2001 Sep;16(9):606-13.

DOI 10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x | PMID 11556941

P27 The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults.

Kelly Posner, Gregory K Brown, Barbara Stanley et al. The American journal of psychiatry. 2011 Dec;168(12):1266-77.

DOI 10.1176/appi.ajp.2011.10111704 | PMID 22193671

P28 TEMPS-A: validation of a short version of a self-rated instrument designed to measure variations in temperament.

Hagop S Akiskal, Mauro V Mendlowicz, Girardin Jean-Louis et al. Journal of affective disorders. 2005 Mar;85(1-2):45-52.

DOI 10.1016/j.jad.2003.10.012 | PMID 15780675

P29 Risk factors for suicide in individuals with depression: a systematic review.

Keith Hawton, Carolina Casañas I Comabella, Camilla Haw et al. Journal of affective disorders. 2013 Feb 12;147(1-3):17-28.

DOI 10.1016/j.jad.2013.01.004 | PMID 23411024

P30 International Society for Bipolar Disorders Task Force on Suicide: meta-analyses and meta-regression of correlates of suicide attempts and suicide deaths in bipolar disorder.

Ayal Schaffer, Erkki T Isometsä, Leonardo Tondo et al. Bipolar disorders. 2015;17(1):1-16.

DOI 10.1111/bdi.12271 | PMID 25329791

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 7

P31 Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review.

Edward Chesney, Guy M Goodwin, Seena Fazel. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2014 Jun;13(2):153-60.

DOI 10.1002/wps.20128 | PMID 24890068

P32 Predicting suicidal behaviours using clinical instruments: systematic review and meta-analysis of positive predictive values for risk scales.

Gregory Carter, Allison Milner, Katie McGill et al. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 2017;210(6):387-395.

DOI 10.1192/bjp.bp.116.182717 | PMID 28302700

P33 Mixed features of depression: why DSM-5 is wrong (and so was DSM-IV).

Athanasios Koukopoulos, Gabriele Sani, S Nassir Ghaemi. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 2013 Jul;203(1):3-5. Editorial.

DOI 10.1192/bjp.bp.112.124404 | PMID 23818531

P34 Prevalence and characteristics of undiagnosed bipolar disorders in patients with a major depressive episode: the BRIDGE study.

Jules Angst, Jean-Michel Azorin, Charles L Bowden et al. Archives of general psychiatry. 2011 Aug;68(8):791-8.

DOI 10.1001/archgenpsychiatry.2011.87 | PMID 21810644

P35 Mixed features in patients with a major depressive episode: the BRIDGE-II-MIX study.

Giulio Perugi, Jules Angst, Jean-Michel Azorin et al. The Journal of clinical psychiatry. 2015 Mar;76(3):e351-8.

DOI 10.4088/JCP.14m09092 | PMID 25830457

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 8

P36 **Deconstructing major depressive episodes across unipolar and bipolar depression by severity and duration: a cross-diagnostic cluster analysis on a large, international, observational study.**

Filippo Corponi, Gerard Anmella, Isabella Pacchiarotti et al. Translational psychiatry. 2020 Jul 19;10(1):241.

DOI 10.1038/s41398-020-00922-2 | PMID 32684621

P37 **Patterns of response to antidepressants in major depressive disorder: Drug resistance or worsening of depression are associated with a bipolar diathesis.**

Giulio Perugi, Isabella Pacchiarotti, Cecilia Mainardi et al. European neuropsychopharmacology. 2019;29(7):825-834.

DOI 10.1016/j.euroneuro.2019.06.001 | PMID 31227264

P38 **The risk of switch to mania in patients with bipolar disorder during treatment with an antidepressant alone and in combination with a mood stabilizer.**

Alexander Viktorin, Paul Lichtenstein, Michael E Thase et al. The American journal of psychiatry. 2014 Oct;171(10):1067-73.

DOI 10.1176/appi.ajp.2014.13111501 | PMID 24935197

P39 **Mania associated with antidepressant treatment: comprehensive meta-analytic review.**

L Tondo, G Vázquez, R J Baldessarini. Acta psychiatrica Scandinavica. 2010;121(6):404-14.

DOI 10.1111/j.1600-0447.2009.01514.x | PMID 19958306

P40 **Bipolar disorder, affective psychosis, and schizophrenia in pregnancy and the post-partum period.**

Ian Jones, Prabha S Chandra, Paola Dazzan et al. Lancet (London, England). 2014 Nov 15;384(9956):1789-99.

DOI 10.1016/S0140-6736(14)61278-2 | PMID 25455249

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 9

P41 Risk of Postpartum Relapse in Bipolar Disorder and Postpartum Psychosis: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Richard Wesseloo, Astrid M Kamperman, Trine Munk-Olsen et al. The American journal of psychiatry. 2016;173(2):117-27.

DOI 10.1176/appi.ajp.2015.15010124 | PMID 26514657

P42 Secondary mania: manic syndromes associated with antecedent physical illness or drugs.

C Krauthammer, G L Klerman. Archives of general psychiatry. 1978 Nov;35(11):1333-9.

DOI 10.1001/archpsyc.1978.01770350059005 | PMID 757997

P43 The interface between borderline personality disorder and bipolar spectrum disorders.

Joel Paris, John Gunderson, Igor Weinberg. Comprehensive psychiatry. 2007;48(2):145-54.

DOI 10.1016/j.comppsych.2006.10.001 | PMID 17292705

P44 HIV infection and psychiatric illness.

B Owe-Larsson, L Säll, E Salamon et al. African journal of psychiatry. 2009 May;12(2):115-28.

DOI 10.4314/ajpsy.v12i2.43729 | PMID 19582313

P45 The prevalence of psychotic symptoms among methamphetamine users.

Rebecca McKetin, Jennifer McLaren, Dan I Lubman et al. Addiction (Abingdon, England). 2006 Oct;101(10):1473-8.

DOI 10.1111/j.1360-0443.2006.01496.x | PMID 16968349

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 10

P46 Gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome.

J E Dyer, B Roth, B A Hyma. Annals of emergency medicine. 2001 Feb;37(2):147-53.

DOI 10.1067/mem.2001.112985 | PMID 11174231

P47 The gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome.

Asim F Tarabar, Lewis S Nelson. Toxicological reviews. 2004;23(1):45-9.

DOI 10.2165/00139709-200423010-00005 | PMID 15298492

P48 Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature.

Steven Maxwell, Maryam Shahmanesh, Mitzy Gafos. The International journal on drug policy. 2019;63:74-89.

DOI 10.1016/j.drugpo.2018.11.014 | PMID 30513473

P49 Mental Health Symptoms Associated with Sexualized Drug Use (Chemsex) among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review.

Daniel Íncera-Fernández, Manuel Gámez-Guadix, Santiago Moreno-Guillén. International journal of environmental research and public health. 2021 Dec 17;18(24):13299.

DOI 10.3390/ijerph182413299 | PMID 34948907

P50 Cannabis use and mania symptoms: a systematic review and meta-analysis.

Melanie Gibbs, Catherine Winsper, Steven Marwaha et al. Journal of affective disorders. 2015;171:39-47.

DOI 10.1016/j.jad.2014.09.016 | PMID 25285897

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 11

P51 **Mephedrone (4-methylmethcathinone; 'meow meow'): chemical, pharmacological and clinical issues.**

Fabrizio Schifano, Antonio Albanese, Suzanne Fergus et al. Psychopharmacology. 2011;214(3):593-602.

DOI 10.1007/s00213-010-2070-x | PMID 21072502

Alcance de la verificación ampliada (3-nov-2026)

Se leyeron en PubMed los metadatos y resúmenes de P19–P51. Las cifras de las pp. 26–42 proceden de esos resúmenes y no se han contrastado con los textos completos. P25 (Hamilton, 1960) no tiene resumen disponible y P33 es un editorial. Las afirmaciones sobre criterios DSM-5-TR de la p. 22 siguen sujetas al cotejo con N4.

Verificación en PubMed: P01–P18, 28-10-2026; P19–P51, 03-11-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017; P25 no tiene resumen en PubMed; P33 es un editorial. Cada entrada enlaza a PubMed.